



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LAPORAN KEGIATAN

KOMITE MUTU RS. PRIMA HUSADA SUKOREJO

BULAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0341 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PERSETUJUAN

**LAPORAN KEGIATAN KOMITE MUTU TRIWULAN I
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2026**

Dalam pembangunan sektor kesehatan, salah satu prakondisi yang harus dipenuhi adalah meningkatkan mutu pelayanan, termasuk mutu pelayanan di rumah sakit agar pengelolaan rumah sakit menjadi lebih efektif dan efisien. Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit prima Husada Sukorejo disusun berdasarkan program kerja yang telah disepakati bersama oleh direktur dan seluruh stake holder yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan nantinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Disusun Oleh :

Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo

Sukorejo, 31 Maret 2026

Telah Disetujui Oleh :

Direktur PT. Disa Prima Medika

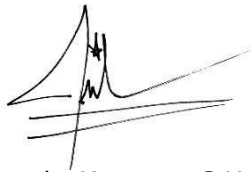


(dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE)

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN KOMITE MUTU TRIWULAN I
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2026

Laporan Kegiatan Komite Mutu RS. Prima Husada digunakan sebagai bahan acuan di unit kerja untuk menjalankan Rencana perbaikan kinerja maupun layanan di unit Kerja Rumah Sakit Prima Husada

Disusun,
Oleh ;
Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo



(Lidia Puspita Kencana, S.K.M.)

Disetujui oleh,
Authorized Person



(Dr.dr.Aslichah M.Kes., AFP, CHAE.)

Disetujui,
Oleh

Direktur RS. Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, SWT karena atas Rahmat-Nya Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Triwulan I Tahun 2026 telah dapat diselesaikan. Laporan ini berisikan kumpulan dari program kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang menjangkau keseluruhan unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Untuk melaksanakan program tersebut tidaklah mudah karena memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala bidang/bagian, keperawatan, penunjang medis, administrasi dan lainnya termasuk kepala unit / instalasi pelayanan.

Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada bulan berikutnya.

Akhir kata, kami dari Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya seluruh program dari Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sehingga tersusunnya laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Triwulan I Tahun 2026. Semoga dengan adanya laporan ini kita dapat meningkatkan mutu layanan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Penyusun

Komite Mutu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN..... i

LEMBAR PENGESAHANii

KATA PENGANTARiii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.2 Tujuan..... 1

1.2.1 Tujuan Umum..... 1

1.2.2 Tujuan Khusus 1

BAB II 2

HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN KOMITE MUTU..... 2

BULAN TRIWULAN I TAHUN 2026 2

2.1 Kegiatan Pokok 2

2.2 Kegiatan yang Dilakukan 3

2.3 Jadwal Kegiatan..... 3

2.4 Pencatatan dan Pelaporan 3

BAB III 1

HASIL KEGIATAN 1

3.1 Pemantauan Indikator Mutu 1

3.1.1 Indikator Mutu Nasional 1

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional..... 1

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit 1

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo 1

3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit..... 1

1. INSTALASI GAWAT DARURAT 1

2. INSTALASI RAWAT JALAN 3

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A..... 4

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B..... 6

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A..... 8

6. INSTALASI RAWAT INAP 3B..... 10

7. INSTALASI KAMAR OPERASI 12

8. MATERNITAS 15

9. PONEK..... 17

10. NEONATOLOGI..... 19

11. ICU..... 21

12. RADIOLOGI..... 23

13. LABORATORIUM 24

14. REHAB MEDIS 26

15. FARMASI 28

16.	GIZI.....	29
17.	REKAM MEDIS.....	31
18.	LIMBAH – K3RS	33
19.	SDM.....	34
20.	KESEKRETARIATAN	36
21.	DRIVER.....	37
22.	PEMULASARAAN JENAZAH	37
23.	ATEM – IPSRS	37
24.	LAUNDRY.....	39
25.	CSSD	39
26.	CLEANING SERVICE	41
27.	KEAMANAN	42
28.	GUDANG UMUM.....	44
29.	PPI.....	44
30.	PKRS.....	46
31.	ASURANSI CENTER	48
32.	HUMAS & MARKETING	48
33.	CSO.....	49
34.	MOD-MPP-PIPP	49
35.	TB di IRJA.....	50
36.	KEUANGAN	Error! Bookmark not defined.
37.	TIM HIV	51
38.	KB	51
39.	STUNTING	52
40.	IT - SIM RS.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi RS Prima Husada Sukorejo adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi RS Prima Husada Sukorejo, maka ditetapkan tiga misi sebagai berikut: (1) memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat, (2) mengutamakan kepuasan pasien, (3) meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Untuk memberikan pelayanan dengan mengutamakan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien RS Prima Husada Sukorejo melakukan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang sesuai dengan Standar Akreditasi Nasional. Kegiatan ini dilakukan di semua unit kerja untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien RS Prima Husada Sukorejo pada tahun 2026 menetapkan indikator rumah sakit sesuai standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dari KARS STARKES berdasarkan standar PMKP 3, dapat diklasifikasikannya indikator rumah sakit sebagai berikut : Indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas Rumah sakit (IMP-RS) yang meliputi : indikator sasaran keselamatan pasien, indikator pelayanan klinis prioritas, indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit, indikator terkait perbaikan sistem dan indikator terkait manajemen resiko, kemudian yang ketiga yakni insikator mutu prioritas unit.

Identifikasi prosedur, proses dan hasil dari kegiatan yang dinilai sebelumnya pada tahun 2025, disertai tujuan untuk menekan permasalahan yang ada di rumah sakit mendasari dipilihnya indikator baru di indikator prioritas. Kriteria pemilihan tetap didasarkan pada kasus yang memiliki volume tinggi, resiko tinggi atau biaya tinggi, disesuaikan dengan visi dan misi rumah sakit. Laporan Komite Mutu pada Triwulan I Tahun 2026 terkait indikator mutu diambil oleh unit kerja.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di setiap unit di RS Prima Husada Sukorejo

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengevaluasi peningkatan mutu RS Prima Husada Sukorejo melalui pemantauan indikator mutu internal atau eksternal berdasarkan standar Komite Mutu Tahun 2025
2. Mengevaluasi program keselamatan pasien dengan pemantauan Insiden Keselamatan Pasien Rumah Sakit (IKP-RS)
3. Mengevaluasi pelaksanaan program mutu lain, yang dilakukan oleh unit terkait dengan peningkatan mutu yakni:
 - a. Program manajemen resiko
 - b. Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di unit kerja
4. Menganalisis capaian indikator mutu unit untuk mendapatkan bahan rekomendasi sebagai rencana tindak lanjut perbaikan di unit

BAB II
HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN KOMITE MUTU
BULAN TRIWULAN I TAHUN 2026

2.1 Kegiatan Pokok

Seperti yang dijelaskan di atas, kegiatan pemantauan indikator mutu Komite Mutu Tahun 2026 yang dilaporkan adalah periode Bulan Triwulan I Tahun 2026. Adapun indikator mutu yang dipantau adalah sebagai berikut:

A) Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan
2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
3. Kepatuhan Identifikasi Pasien
4. Waktu Tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit
5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit
6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit
7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter Spesialis $\leq$ jam 14.00
8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit
9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)
11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh
12. Keterlambatan Respon Terhadap Komplain
13. Kepuasan Pasien

B) Indikator Mutu Prioritas

1. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 - a. Kepatuhan Identifikasi Pasien
 - b. Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR
 - c. Kepatuhan Staf Farmasi dalam Penempelan Stiker LASA dan High Alert
 - d. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien
 - e. Kepatuhan Kebersihan Tangan
 - f. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
2. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas
 - a. Kepatuhan PPK/CP DM Gangren/Ulcus dengan Tindakan Debridement
3. Indikator Berdasarkan Renstra RS
 - a. Presentase Pasien Komplain
 - b. Waktu Tunggu IGD ke Rawat Inap yakni ≤ 6 jam
4. Indikator Perbaikan Sistem
 - a. Waktu Tunggu Layanan Farmasi Obat Jadi < 30 menit
 - b. Waktu Tunggu Layanan Farmasi Obat Racikan < 60 menit
5. Indikator Manajemen Resiko
 - a. Presentase Berkas Pending Klaim
 - b. Angka Kerusakan Alat Medis karena Ketidakpatuhan staf dalam Menjalankan SPO
6. Praktik Klinis yang Di Evaluasi (17 Diagnosis yang di evaluasi)
 - 1) Typhoid Fever (Dewasa dan Anak)
 - 2) Dengue Fever (Dewasa dan Anak)
 - 3) Pneumonia Dewasa
 - 4) Pneumonia Bayi dan Anak
 - 5) DM Gangren/Ulcus dan Tindakan Debridement
 - 6) Soft Tissue Tumor dengan tindakan eksisi
 - 7) Batu Ureter
 - 8) Diabetes Millitus
 - 9) GEA
 - 10) HIV
 - 11) Hipertensi
 - 12) TB
 - 13) Keganasan (Ca Mammae)
 - 14) Pneumonia
 - 15) SC
 - 16) Partus Normal
 - 17) PEB
 - 18) BPH

-
- 19) Hydronefrosis
 - 20) PPOK
 - 21) Fraktur terbuka
 - 22) Stroke hemoragik
 - 23) Stroke Trombosis

2.2 Kegiatan yang Dilakukan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu secara berkesinambungan
2. Melakukan analisis hasil capaian mutu indikator di unit kerja
3. Melakukan rencana tindak lanjut untuk perbaikan capaian atau mencapai target yang ditentukan
4. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu di unit kerja
5. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu

2.3 Jadwal Kegiatan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu di unit kerja secara berkesinambungan
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu (dilakukan setiap bulan)
3. Melakukan pelaporan hasil pemantauan indikator di unit kerja setiap bulan, serta menyusun program perbaikan mutu dengan teknik PDSA oleh penanggungjawab penggumpul data unit di koordinasikan dengan komite Mutu
4. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit setiap satu bulan.
5. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien RS Prima Husada Sukorejo dengan hasil banchmarking perbandingan capaian mutu dengan RS lain setiap tiga bulan sekali.

2.4 Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan oleh penanggungjawab data mutu unit, kemudian dilakukan rekapitulasi dan analisa oleh penanggungjawab. Data hasil pemantauan ditulis pada form laporan harian mutu dan dilakukan validasi kepada kepala unit untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah benar dan valid. Jika data sudah valid selanjutnya akan dilakukan analisis data untuk mencari rencana tindak lanjut bagi indikator mutu yang masih belum mencapai target atau standar yang ditetapkan. Hasil pengolahan dan analisis data dituangkan dalam laporan tertulis kemudian akan dilaporkan kepada penanggungjawab mutu rumah sakit setiap bulan dalam rapat koordinasi mutu bulanan.

Penanggung jawab mutu Rumah Sakit selanjutnya akan menentukan langkah untuk membuat rencana tindak lanjut indikator mutu yang belum sesuai targert sebagai bentuk feedback dari pelaporan penanggung jawab mutu di unit.

BAB III
HASIL KEGIATAN

3.1 Pemantauan Indikator Mutu

Berikut merupakan hasil pemantauan indikator mutu RS. Prima Husada Sukorejo yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026.

3.1.1 Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026.

Tabel 3.1 Indikator Mutu Nasional

No	Judul Indikator Mutu Nasional	Standar
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	≥80%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	≥80%
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	≤5%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	≥80%
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥80%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%
13	Kepuasan Pasien	≥76.61%

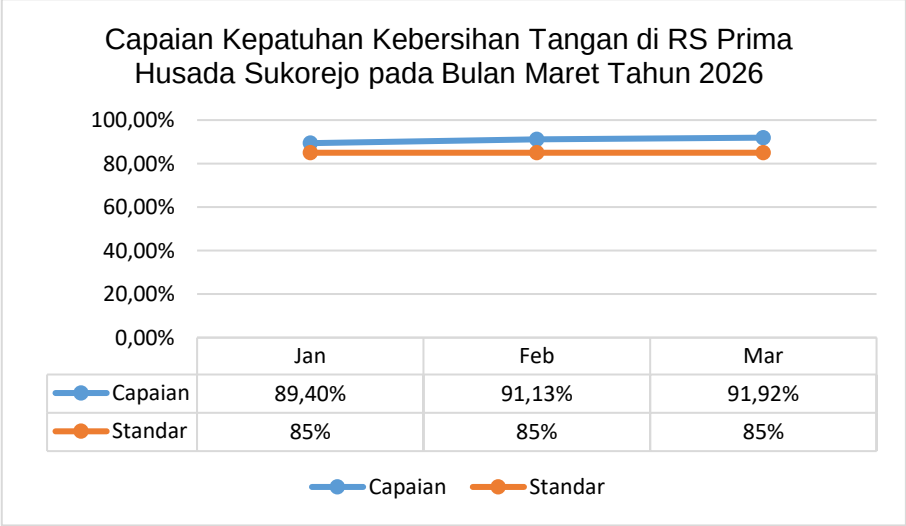
Tabel 3.2 Capaian Indikator Mutu Nasional RSPH Sukorejo Bulan Triwulan I Tahun 2026

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	89,40%	91,13%	91,92%										≥85%	90,82%	Dipertahankan
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	96,54%	93,82%	94,94%										100%	95,10%	PDSA
3	Kepatuhan identifikasi pasien	99,04%	99,51%	99,51%										100%	99,35%	PDSA
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	80%	80%	78,13%										≥80%	79,38%	PDSA
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	98,12%	85,61%	85,83%										≥80%	89,85%	Dipertahankan
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	2,14%	1,28%	1,14%										≤5%	1,52%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	66,21%	72,78%	72,05%										≥80%	70,35%	PDSA
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
9	Kepatuhan Penggunaan	98,24%	98,91%	95,27%										≥80%	97,47%	Dipertahankan

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	Formularium Nasional															
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	99,39%	99,53%	99,60%										≥80%	99,51%	Dipertahankan
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	98,02%	98,09%	98,04%										100%	98,05%	PDSA
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	96,15%	94,74%										≥80%	96,96%	Dipertahankan
13	Kepuasan Pasien	91,80%	88,10%	89,74%										≥76.61%	89,88%	Dipertahankan

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan

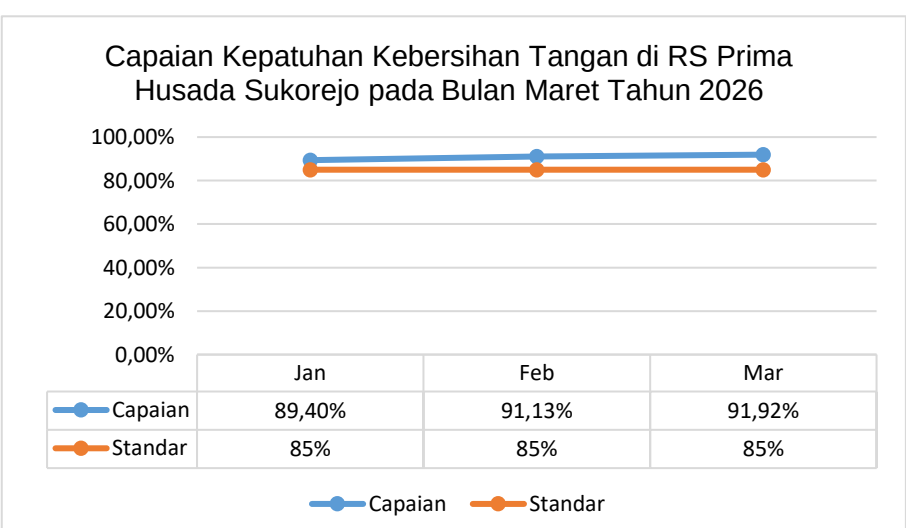


Gambar 3.1. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Bulan Triwulan I yakni mencapai 90,81%. Dari 3234 petugas yang diobservasi yang melakukan patuhan dengan benar yakni 2936 petugas. Capaian sebesar **90,82%** ini menandakan bahwa mayoritas besar petugas (2936 dari 3234 orang) telah menerapkan prosedur cuci tangan sesuai dengan protokol yang berlaku. Meskipun angka ini sudah berada di kategori tinggi, upaya monitoring tetap diperlukan untuk menjangkau sisa petugas yang belum konsisten dalam kepatuhan.

2. Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar 3.2. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa:

Berdasarkan data capaian kepatuhan penggunaan APD diatas pada Bulan Triwulan I yakni mencapai 90,81%. Dari 3234 petugas yang diobservasi terkait kepatuhan penggunaan APD, 2936 petugas patuh dalam pemakaian APD.

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Triwulan I Tahun 2026

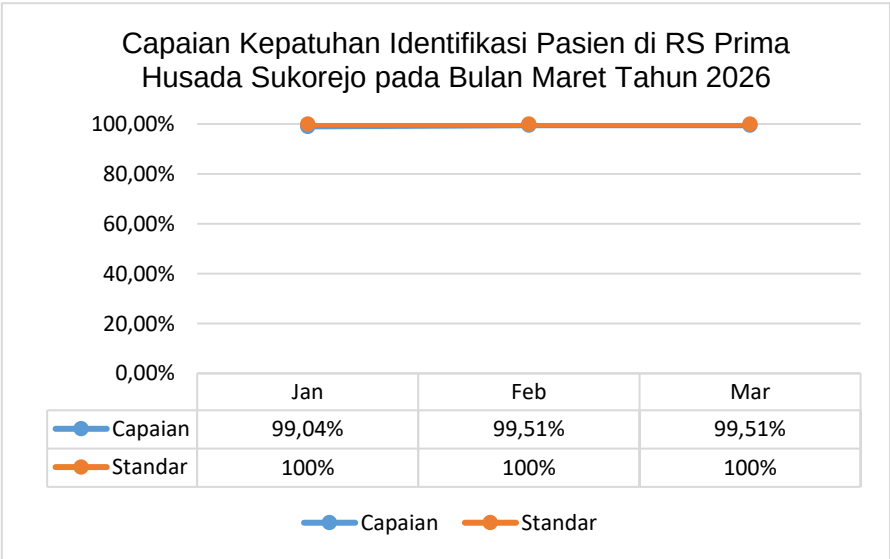
Problem	Capaian kepatuhan APD bulan Triwulan I sebesar 90,81% masih belum mencapai standar minimal (100%). Terdapat gap sebesar 9,19% yang berisiko pada
---------	--

	keselamatan petugas dan pasien. Masalah utama diidentifikasi pada faktor perilaku (kejenuhan), serta pelaporan yang sempat terhenti
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan
Plan	1. Objective: Mencapai kepatuhan APD 100% melalui supervisi ketat dan edukasi risiko infeksi 2. Siapa: Tim PPI, Tim Mutu, dan Supervisor Unit 3. Memberikan pengingat visual di area kerja (poster, stiker, digital signal) 4. Supervisi rutin oleh IPCN/IPCLN 5. System reward bulanan unit dengan kepatuhan 100% 6. Simulasi kasus nyata resiko infeksi akibat ketidakpatuhan
Do	1. Lakukan pemasangan materi edukasi dan pengingat di setiap unit 2. Lakukan audit dan observasi harian 3. Berikan umpan balik mingguan dan apresiasi bagi tenaga yang patuh 4. Lakukan survei kecil mengenai kenyamanan dan persepsi staff tentang APD
Study	1. Hasil Kuantitatif: Capaian Maret 94,94% (806/849). Meskipun tinggi, secara regulasi ini dianggap "Tidak Tercapai" karena standar adalah 100%. 2. Ketidakpatuhan dalam penggunaan APD dikarenakan petugas merasa tidak nyaman menggunakan APD, merasa bahwa risiko infeksi sudah menurun sehingga kepatuhan bisa longgar, serta ketidakteraturan pengawasan unit
Action	1. Perwakilan Komite PMKP dan PPI akan menghadiri rapat rutin di setiap unit (Rawat Inap, IGD, IKO, dll). Tujuannya adalah memaparkan data ketidakpatuhan secara transparan dan membahas kendala spesifik di lapangan

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Perwakilan Komite PMKP dan PPI akan menghadiri rapat rutin di setiap unit pelayanan (Rawat Inap, IGD, IKO , dll). Tujuannya adalah memaparkan data ketidakpatuhan secara transparan dan membahas kendala spesifik di lapangan	Memaparkan data ketidakpatuhan secara transparan dan membahas kendala spesifik di lapangan.	Seluruh Staf Klinis dan Non-Klinis di Unit Pelayanan.	Diseminasi Data: Presentasi hasil audit bulanan dan diskusi dua arah mengenai kendala teknis/fasilitas	Komite PMKP & Komite PPI	1 bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo Pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I 2026 mencapai 99,35%. Dari 14224 petugas yang diobservasi ditemukan 14131 petugas yang patuh terhadap identifikasi pasien. Capaian ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan secara konsisten telah menerapkan standar keselamatan pasien, khususnya dalam hal identifikasi menggunakan dua identitas yang benar (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis), sebelum melakukan tindakan medis maupun keperawatan.

Tabel 3.5 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Triwulan I Tahun 2026

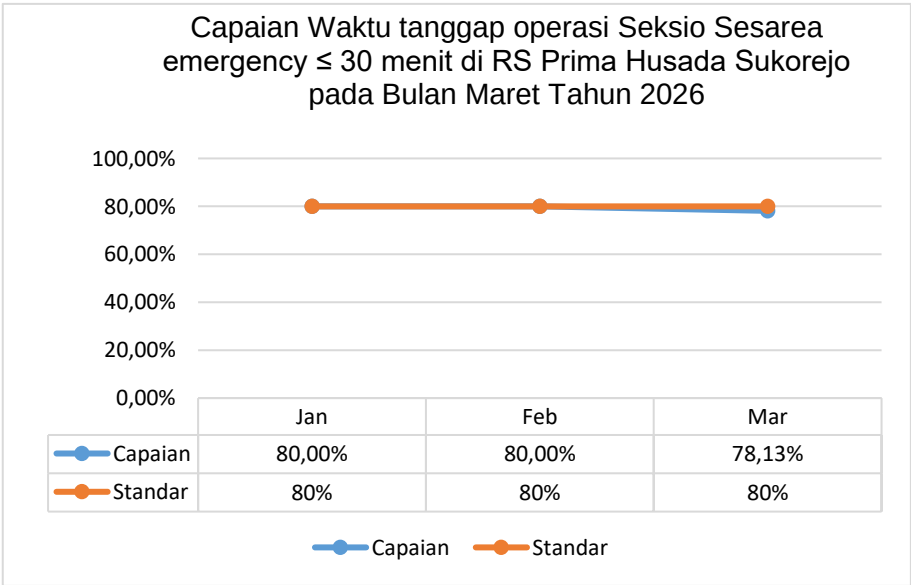
Problem	Meskipun capaian kepatuhan identifikasi pasien pada Triwulan I sangat tinggi (99,35%), masih ditemukan 39 petugas (0,65%) dari 6.097 observasi yang belum patuh. Ditemukan kegagalan telusur pada 39 observasi di mana petugas tidak melakukan pengecekan gelang identitas sebelum melakukan tindakan krusial seperti: a. Pemberian Injeksi (Analgesik/Obat lain) b. Edukasi Relaksasi Napas Dalam c. Pengambilan Sampling Darah d. Pemeriksaan Gula Darah (GDA) e. Monitoring TTV f. Pemasangan Infus g. Transfusi Darah h. Pemberian Nebulisasi Hal ini menunjukkan adanya gap antara "bertanya nama" dengan "verifikasi identitas pada gelang", yang merupakan standar baku keselamatan pasien
Step	1. Mengidentifikasi data <i>by name</i> dan unit asal dari 30 petugas yang tidak melakukan verifikasi gelang untuk memetakan area dengan risiko tertinggi. 2. Melakukan wawancara kepada 30 petugas terkait dengan alasan ketidakpatuhan dalam melakukan identifikasi pasien.
Plan	1. Objective: Mencapai 100% verifikasi gelang pada setiap tindakan medis dan keperawatan. 2. Strategi: Mewajibkan ritual "Lihat, Baca, dan Cocokkan" sebelum menyentuh pasien untuk tindakan apa pun. 3. Menjadwalkan kehadiran perwakilan Komite PMKP pada rapat rutin bulanan di setiap unit pelayanan untuk diseminasi data.
Do	1. Edukasi "On-the-Spot": Menegur langsung saat petugas terlihat hanya bertanya nama tanpa melihat gelang saat akan menyuntik atau mengambil darah 2. Menyerahkan data (<i>by name</i>) kepada Kepala Unit untuk dilakukan pembinaan mengenai identifikasi pasien 3. Perwakilan Komite PMKP menghadiri rapat dan mengevaluasi capaian mutu

Study	- Hasil Analisis: Petugas cenderung melewati cek gelang pada tindakan rutin (seperti monitoring TTV atau GDA) karena merasa tindakan tersebut "ringan", padahal kesalahan identitas pada TTV atau GDA tetap dapat mengakibatkan salah diagnosa dan salah terapi oleh dokter. - Tindakan seperti "Injeksi Analgesik" dan "Sampling Darah" adalah titik kritis yang paling berbahaya jika gelang tidak dicek.
Action	- Menstandarisasi paparan data ketidakpatuhan dalam agenda tetap rapat rutin unit (IGD, IKO, Rawat Inap) sebagai bentuk transparansi mutu. - Mengintegrasikan kepatuhan identifikasi pasien ke dalam Indikator Kinerja Individu agar menjadi syarat dalam penilaian berkala seluruh staf medis dan keperawatan.

Tabel 3.6 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Menstandarisasi paparan data ketidakpatuhan dalam agenda tetap rapat rutin unit (IGD, IKO, Rawat Inap) sebagai bentuk transparansi mutu.	Memaparkan data data ketidakpatuhan secara transparan dan mengidentifikasi kendala spesifik di lapangan.	Kepala Unit dan seluruh staf klinis (Rawat Inap, IGD, IKO, dll)	Diseminasi Data Faktual: Menyajikan perbandingan data kepatuhan antar unit dan diskusi solusi atas kendala "tidak cek gelang".	Komite PMKP	1 bulan
2	Mengintegrasikan kepatuhan identifikasi pasien ke dalam Indikator Kinerja Individu agar menjadi syarat dalam penilaian berkala seluruh staf medis dan keperawatan.	Meningkatkan kedisiplinan staf dan memastikan prosedur "Lihat, Baca, Cocokkan" dijalankan 100%.	Staf yang tidak patuh dalam observasi.	Kepala Ruangan memasukkan poin pelanggaran identifikasi ke dalam evaluasi kinerja staf.	Kepala Ruangan	Periode penilaian kinerja berjalan

4. Waktu Tunggu Operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 Menit



Gambar 3.4. Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa :

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2026 belum mencapai standar yakni 79,37%. Dari 72 pasien yang diobservasi, 15 pasien yang mendapatkan

pelayanan tanggap SC Emergency diatas dari 30 menit. Secara keseluruhan Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO belum dapat melakukan koordinasi dengan baik.

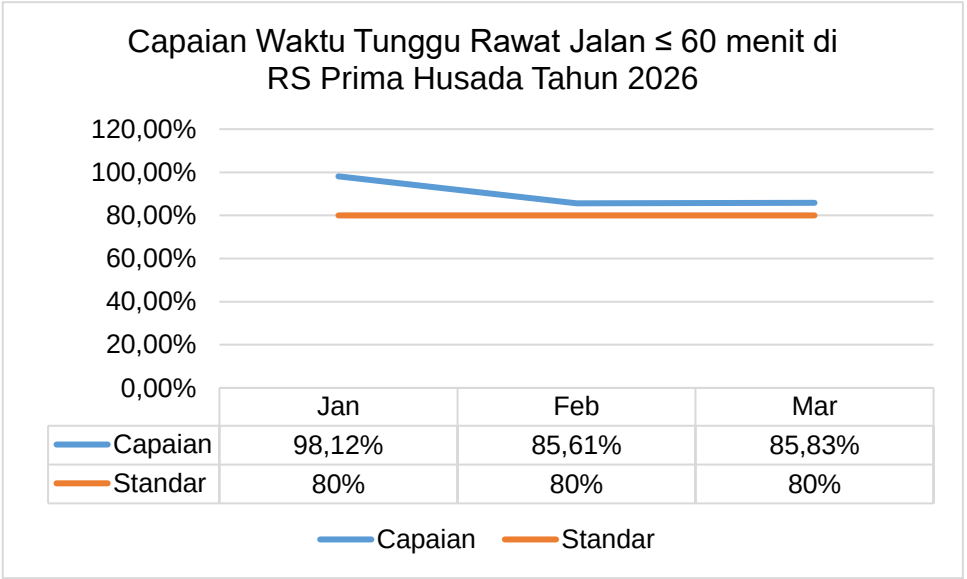
Tabel 3.7 PDSA Capaian Waktu Tanggap SC Emergency ≤ 30 Menit pada Bulan Maret Tahun 2026

Problem	Capaian waktu tanggap SC Emergency ≤ 30 Menit pada Triwulan I adalah 79,37%. Masih terdapat gap 0,63% dari standar 80% sehingga dapat berisiko pada keselamatan pasien.
Step	1. Mengidentifikasi alasan keterlambatan waktu tanggap SC Emergency melalui data laporan dan wawancara PIC dari unit Maternitas dan Ponek. 2. Hasilnya diketahui jarak tempuh dari kediaman dokter ke RS rata-rata memakan waktu > 30 menit sehingga target sulit tercapai
Plan	1. Objective: mencapai target waktu SC Emergency ≥ 80 menit 2. Melakukan sosialisasi dan supervisi terhadap kepatuhan waktu tanggap SC Emergency ≤ 30 Menit
Do	1. Melakukan pertemuan koordinasi dengan tim Ponek dan Maternitas untuk menyosialisasikan pentingnya kepatuhan waktu tanggap ≤ 30 menit. 2. Melakukan supervisi langsung pada saat terjadi kasus SC Emergency untuk memastikan prosedur pemanggilan dokter dilakukan tepat waktu.
Study	Kasus keterlambatan disebabkan oleh jarak tempuh DPJP yang > 30 menit karena pada saat Emergency DPJP tidak di Rumah Sakit, kecuali DPJP sudah stan by di Rumah Sakit
Action	1. Sosialisasi kepada seluruh staf dan DPJP mengenai kepatuhan waktu tanggap seksio sesarea emergency <30 menit 2. Supervisi dan evaluasi secara berkala

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi kepada seluruh staf dan DPJP mengenai kepatuhan waktu tanggap seksio sesarea emergency <30 menit	Meningkatkan pemahaman staf dan DPJP terkait target mutu	Seluruh staf Ponek, OK, Anestesi, dan DPJP Obgyn	Melakukan Sosialisasi ulang mengenai SPO SC Emergency < 30 menit serta memaparkan data gap 1,87% bulan Maret sebagai dasar evaluasi	Komite PMKP & Kepala Ruangan	1 bulan
2	Supervisi dan evaluasi secara berkala	Memastikan kepatuhan prosedur di lapangan	Memastikan kepatuhan prosedur di lapangan	Melaksanakan Supervisi langsung pada setiap kasus SC Cito untuk memantau waktu respon mulai dari keputusan dokter sampai insisi	Komite PMKP & Kepala Ruangan	Periode penilaian kinerja berjalan

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



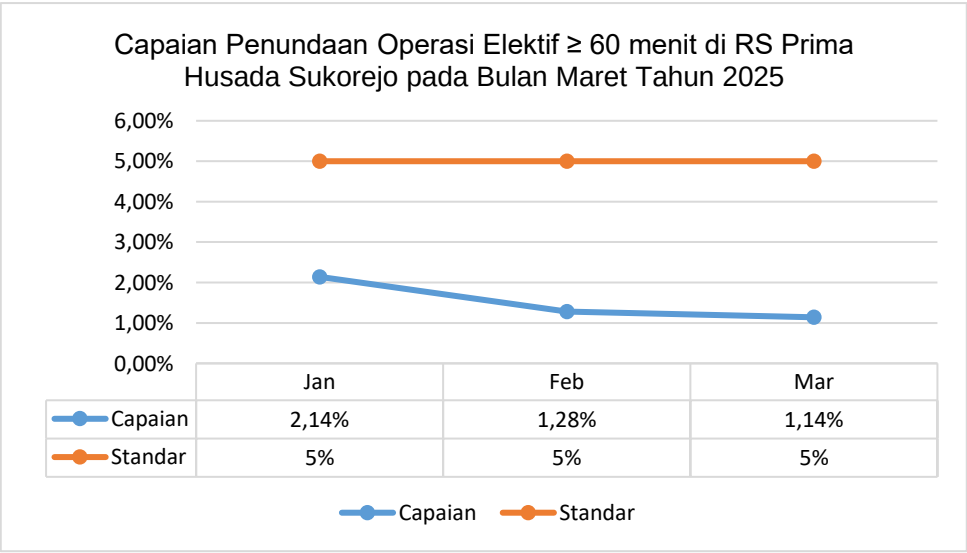
Gambar 3.5. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS. Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2026 mencapai 89,85%. Hasil capaian ini berarti dari total pasien yang terdaftar dan menunggu poli, yakni 21.449 pasien. Total pasien yang berhasil menunggu dan dilayani dokter dalam waktu kurang dari 60 menit adalah sebanyak 19272 pasien. Capaian 89,85% ini **telah melampaui** standar minimum yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Kesehatan, yaitu ≥ 80%. Dengan rata – rata waktu tunggu poli yakni 57 menit. Data ini diambil dalam fitur **Antrian Online** dari **Mobile JKN**.

Capaian diatas mengartikan rumah sakit memanfaatkan fitur **Antrian Online** dari **Mobile JKN** secara maksimal, sehingga pasien datang sudah terdaftar dan siap dilayani (mengurangi *waiting time* di loket). Dan juga data yang diambil langsung dari *database* BPJS lebih akurat, mengurangi waktu yang terbuang untuk koreksi data administrasi.

6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit



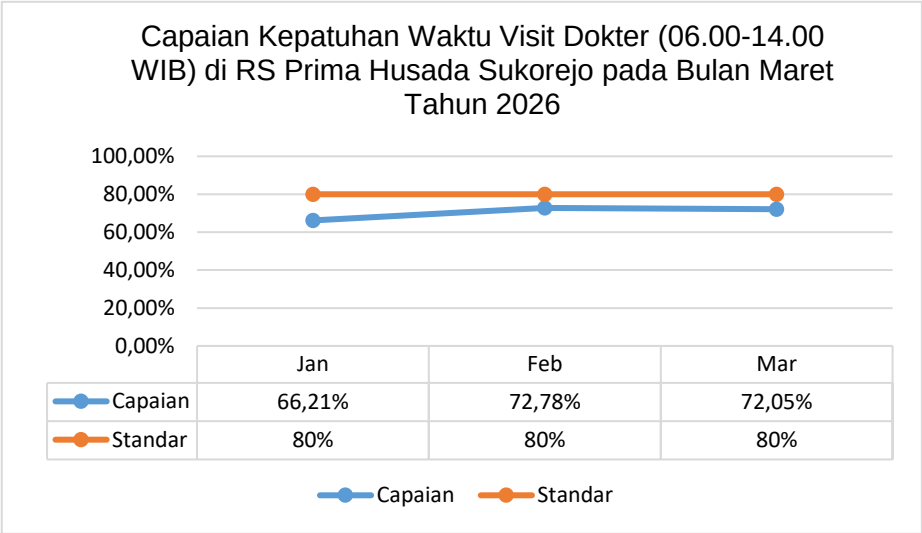
Gambar 3.6. Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026.

Analisa :

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I tahun 2026 yakni 1,52%. Capaian ini sudah mencapai standar < 5 %. Ini dikarenakan dari 950 pasien yang diobservasi 15 pasien dengan operasi elektif yang mengalami penundaan lebih dari 1 jam. Faktor pendukung keberhasilan ini dikarenakan:

- b. Kesiapan pasien: proses administrasi, pemeriksaan penunjang (laboratorium/rontgen) dan puasa pasien dilakukan dengan tepat
- c. Kehadiran dokter operator, dokter anestesi dan perawat tim IKO tepat sesuai jadwal
- d. Ketersediaan alat bedah yang steril siap digunakan tepat waktu sesuai antrean operasi
- e. Perpindahan pasien dari ruang rawat inap ke ruang IKO sesuai jadwal

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis ≤ jam 14.00 WIB



Gambar 3.7. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB) di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa :

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap, diperoleh rata-rata capaian sebesar 70,34% belum memenuhi standar minimal ≥ 80%. Ini dikarenakan dari 2335 yang dibservasi dalam visite ke pasien, 1641 pasien yang di visit dokter kurang dari jam 14.00 WIB.

Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter pada Triwulan I Tahun 2026

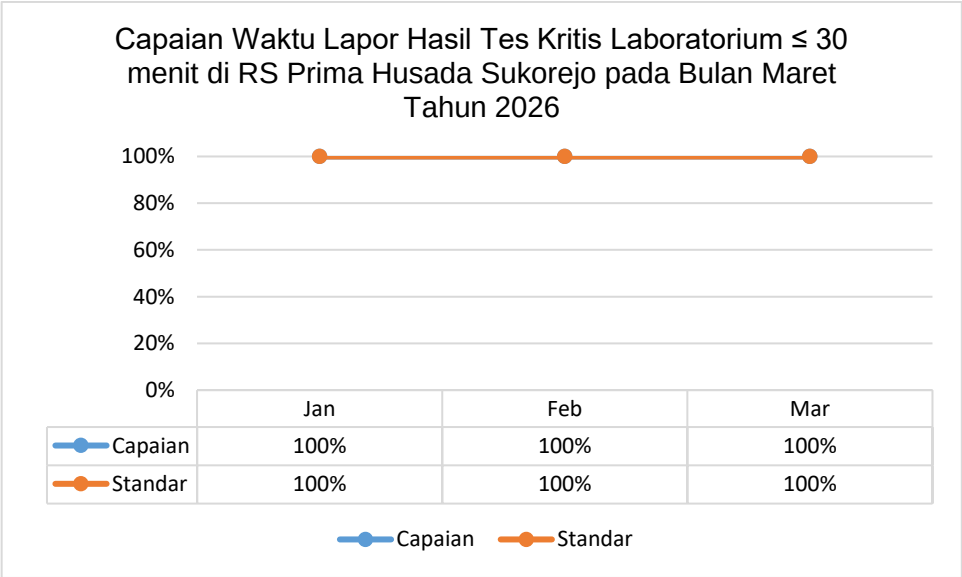
Problem	Capaian waktu visite dokter spesialis pada bulan Triwulan I 2026 sebesar 70,34%, masih di bawah standar minimal ≥ 80%. Dari 2335 observasi, terdapat 694 pasien yang mendapatkan visite di atas jam 14.00 WIB. Kondisi ini berisiko menunda rencana terapi dan proses pemulangan pasien.
Step	1. Mapping Jadwal: Mengidentifikasi jam praktik dokter spesialis di RS lain untuk menentukan prioritas kunjungan pagi. 2. Review Progress Rekrutmen: Melakukan koordinasi dengan bagian SDM mengenai status rekrutmen dokter ruangan (dokter tetap) untuk mengisi kekosongan tenaga medis pendamping.
Plan	1. Objective: Meningkatkan kepatuhan visite menjadi ≥ 80% dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. 2. Strategi: Mempercepat proses rekrutmen dokter ruangan dan meningkatkan peran perawat senior dalam memfasilitasi persiapan asuhan medis.
Do	1. Percepatan Rekrutmen: Bagian SDM memprioritaskan seleksi dokter ruangan agar segera ada tenaga medis yang <i>standby</i> di RS. 2. Perawat ruangan secara aktif menyiapkan kelengkapan pemeriksaan (berkas/hasil penunjang) agar saat dokter spesialis datang di sela jadwal praktiknya, proses visite bisa berlangsung lebih cepat.
Study	Apa yang anda pelajari? Apakah sesuai target capaian? 1. Capaian bulan Triwulan I sebesar 70,34% masih berada di bawah target standar minimal ≥ 80%. 2. Mayoritas dokter spesialis memiliki jadwal praktik di Rumah Sakit lain atau Klinik pada jam utama (06.00 – 14.00 WIB), sehingga waktu untuk melakukan visite di RS Prima Husada Sukorejo menjadi sangat terbatas dan sering tergeser ke atas jam 14.00 WIB. 3. Saat ini belum tersedia Dokter Ruangan karena proses rekrutmen masih berjalan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya tenaga medis tetap yang dapat membantu melakukan pemeriksaan awal atau mendampingi dokter spesialis saat visite pagi.

	4. Beban Kerja Tinggi: Terbatasnya jumlah dokter <i>home base</i> menyebabkan penumpukan beban visite pasien rawat inap pada dokter mitra yang memiliki mobilitas tinggi antar fasilitas kesehatan. 5. Dampak Operasional: Ketidakpatuhan waktu visite ini berdampak pada tertundanya rencana asuhan pasien (pemeriksaan penunjang/terapi) serta menghambat proses pemulangan pasien (<i>discharge</i>) tepat waktu
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan siklus PDSA yang telah dijalankan pada bulan Triwulan I 2026, dapat disimpulkan bahwa: 1. Capaian kepatuhan waktu visite dokter spesialis (70,34%) belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan ($\geq 80\%$). 2. Akar masalah utama bersifat sistemik, yaitu adanya bentrok jadwal praktik dokter di fasilitas kesehatan lain pada jam utama (06.00–14.00 WIB) serta kekosongan posisi Dokter Ruangan yang saat ini masih dalam proses rekrutmen. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Melaksanakan proses rekrutmen terbuka dokter umum di bulan Triwulan I 2026 untuk ditempatkan sebagai dokter ruangan (Senin-Jumat dan Sabtu). 2. Evaluasi Penempatan: Melakukan orientasi cepat bagi dokter ruangan baru mengenai standar akreditasi dan prosedur visite sebelum jam 14.00 WIB agar dampak kehadirannya langsung terasa pada capaian indikator bulan berikutnya

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pelaksanaan <i>Open Recruitment</i> (Rekrutmen Terbuka) Dokter Umum sebagai dokter ruangan	Memenuhi kebutuhan Dokter Ruangan agar proses pendelegasian visite di hari kerja (Senin-Jumat) dan Sabtu berjalan optimal tanpa membebani Dokter IGD.	Tenaga Medis (Dokter Umum).	Mempublikasikan lowongan kerja secara luas dan melakukan seleksi cepat untuk mengisi posisi dokter ruangan khusus <i>home-base</i> .	SDM dan Kabid Pelayanan Medis.	Triwulan I 2026
2	Orientasi Khusus & Sosialisasi Standar Akreditasi	Memastikan dokter baru memahami prosedur visite tepat waktu sebelum jam 14.00 WIB	Dokter Ruangan Baru	Memberikan <i>briefing</i> mendalam mengenai indikator mutu nasional (INM) dan dampak kepatuhan visite terhadap keselamatan pasien.	Komite PMKP, Bidang Pelayanan, SDM	Saat awal penempatan

8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 60 menit

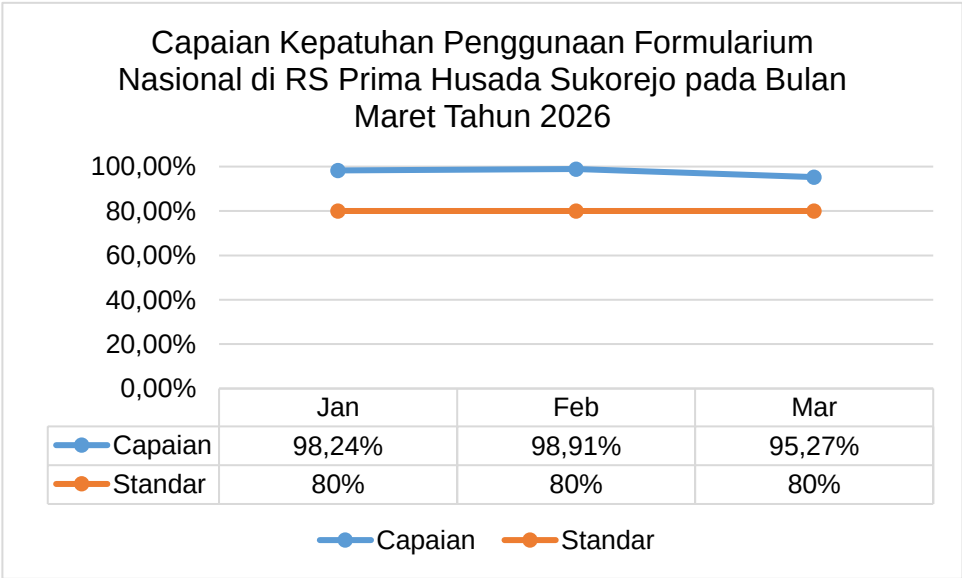


Gambar 3.8. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada Triwulan I Tahun 2026 yakni 100% sesuai standar. Dari hasil kritis laboratorium di observasi, hasil tes kritis sudah dilaporkan kurang dari 30 menit. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

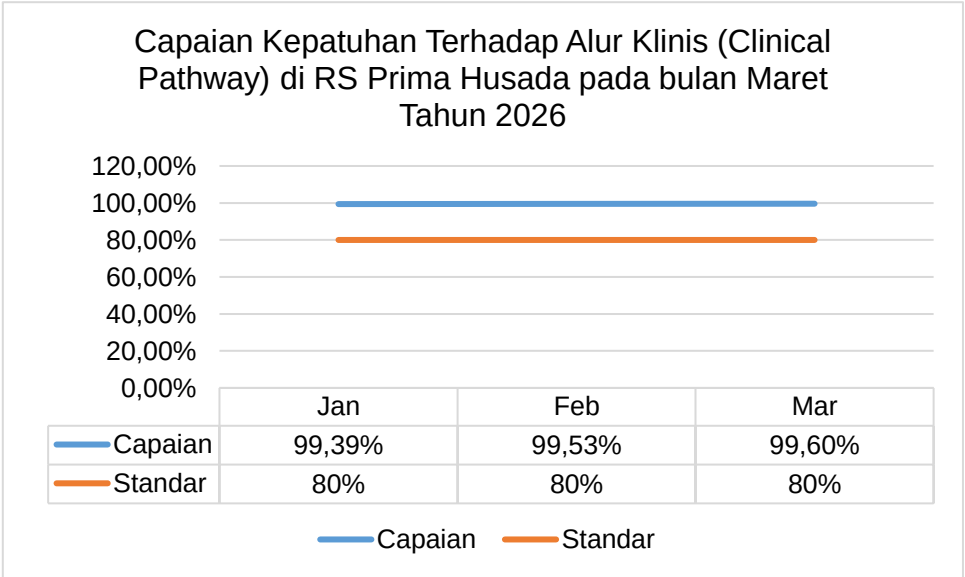


Gambar 3.9. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai standar yakni 97,47%. Unit Farmasi melakukan peresepan obat hanya dari Formularium Nasional. Dari 1853 obat yang diobservasi yang sesuai dengan formularium nasional adalah 1806 obat.

10.Kepatuhan terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

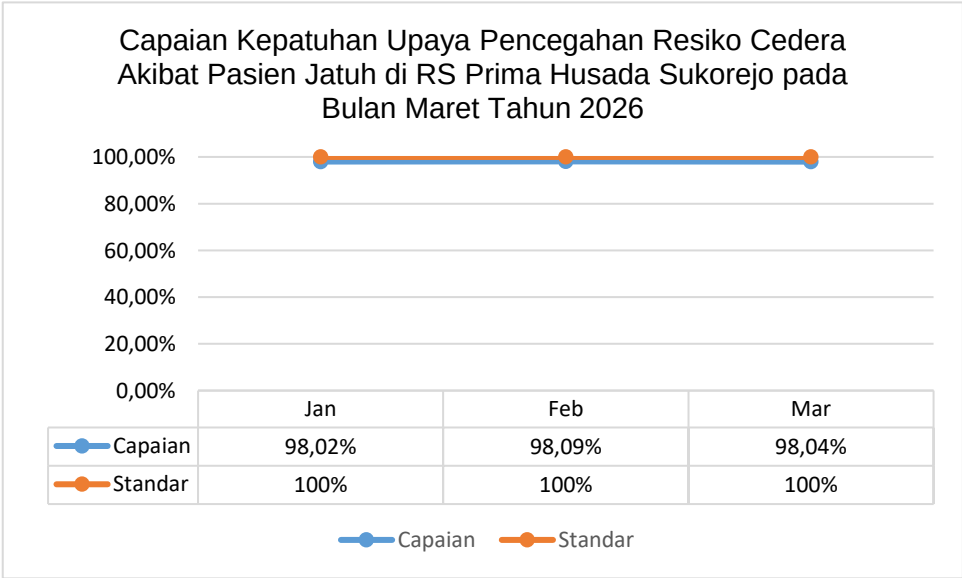


Gambar 3.10. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai standar yakni 99,50%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%. Adapun Kriteria yang diukur adalah LOS (*Length of Stay*), Asesmen Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Obat yang diberikan kepada pasien, Asesmen Keperawatan, Asesmen gizi dan Asesmen Farmasi. Clinical Pathway Bulan Triwulan I didapatkan dari diagnosa PEB, Partus Normal, Seksio Cesarea dan Demam Tifoid pada Anak.

11.Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 3.11. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Triwulan I tahun 2026 adalah 98,05%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 3744 pasien yang diobservasi, 3670 pasien dilakukan upaya pencegahan risiko jatuh secara benar

Tabel 3.11 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2026

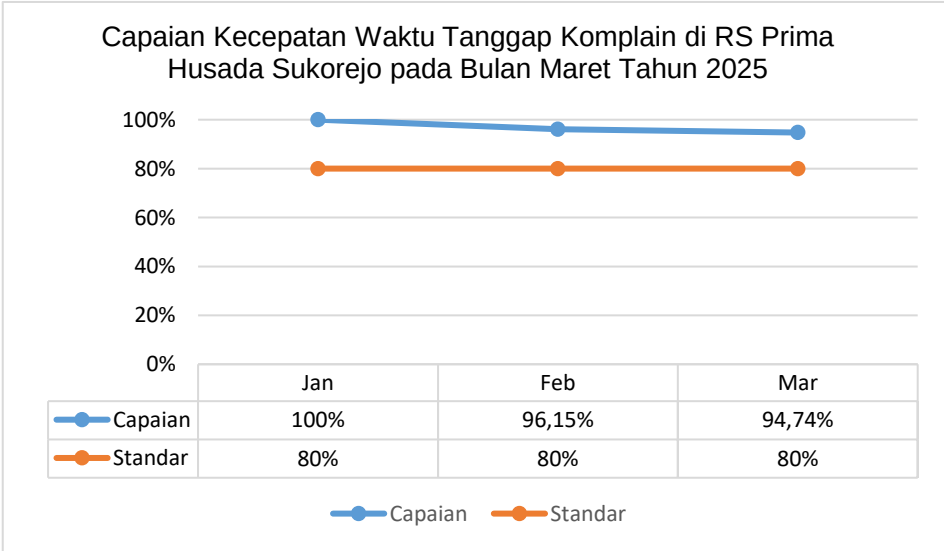
Problem	Capaian kepatuhan pencegahan risiko pasien jatuh pada Triwulan I 2026 sebesar 98,05%, masih di bawah target mutlak 100%. Dari 3.744 pasien, terdapat 73 pasien (1,95%) yang tidak mendapatkan perlindungan risiko jatuh secara standar. Berdasarkan audit visual, ditemukan: 1. Pasien risiko tinggi tidak ada tanda risiko jatuh di bed pasien. 2. <i>Handrail</i> tempat tidur tidak terpasang/terkunci. 3. Kurangnya edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pencegahan jatuh.
Step	1. Audit Logistik: Memastikan ketersediaan stok stiker risiko jatuh di setiap <i>nurse station</i>. 2. Pengecekan Fasilitas: Melakukan inspeksi terhadap kondisi <i>handrail</i> tempat tidur di seluruh ruang perawatan untuk memastikan fungsi kuncinya masih baik.
Plan	1. Objective: Mencapai tingkat kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh sebesar 100% pada periode audit berikutnya melalui penguatan pengawasan fasilitas dan edukasi keluarga. 2. Strategi: Optimalisasi Penandaan: Mewajibkan pemasangan tanda resiko jatuh pada tempat tidur segera setelah skor asesmen menunjukkan risiko tinggi.
Do	1. Pemasangan Atribut: Petugas wajib memasang stiker kuning di bed pasien segera setelah asesmen awal menunjukkan skor risiko tinggi. 2. Perawat memberikan edukasi singkat kepada keluarga pasien mengenai cara menjaga <i>handrail</i> tetap terpasang dan cara memanggil bantuan.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Ketidakpatuhan (1,91%) sering terjadi karena petugas lupa memasang tanda resiko jatuh saat pasien baru datang atau saat beban kerja tinggi. 2. <i>Handrail</i> yang tidak terpasang sering kali disebabkan oleh keluarga pasien yang menurunkannya dan perawat tidak segera mengecek ulang saat ronde.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Bulan Triwulan I Tahun 2026 belum sesuai standar yakni 98,05% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Rapat Koordinasi Unit: Memaparkan temuan 73 pasien tidak patuh tersebut dalam rapat unit sebagai pengingat risiko cedera kepala atau patah tulang jika pasien jatuh. 2. Evaluasi Kinerja: Nama petugas yang bertanggung jawab pada 73 kasus ketidakpatuhan tersebut diserahkan kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam penilaian kinerja bulanan. 3. Redesign Monitoring: Mewajibkan pengecekan <i>handrail</i> menjadi bagian dari <i>checklist</i> operan perawat setiap pergantian <i>shift</i>.

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rapat Koordinasi Unit	Meningkatkan kesadaran staf mengenai urgensi pencegahan cedera (patah tulang/cedera kepala) akibat jatuh.	Seluruh staf klinis di unit rawat inap.	Memaparkan data 73 pasien tidak patuh secara transparan sebagai bahan evaluasi dan pengingat risiko klinis.	Komite PMKP	1 bulan
2	Evaluasi Kinerja dan Pembinaan Personal.	Memastikan akuntabilitas staf dalam menjalankan standar prosedur keselamatan pasien.	73 Petugas yang teridentifikasi tidak patuh.	Performance Integration: Menyerahkan data <i>by name</i> kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam poin penilaian kinerja bulanan.	Kepala Ruangan	1 bulan
3	<i>Redesign Monitoring</i> melalui	Menjamin fasilitas keamanan (<i>handrail</i>) dan	Fasilitas tempat tidur pasien risiko tinggi.	Mewajibkan pengecekan fisik <i>handrail</i> dan stiker sebagai	Perawat Pelaksana & Karu	1 bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
	Checklist Operan.	tanda risiko selalu terpasang di setiap pergantian shift.		item wajib dalam bedside handover (operan di samping bed).		

12. Kepatuhan Waktu Tanggap Komplain

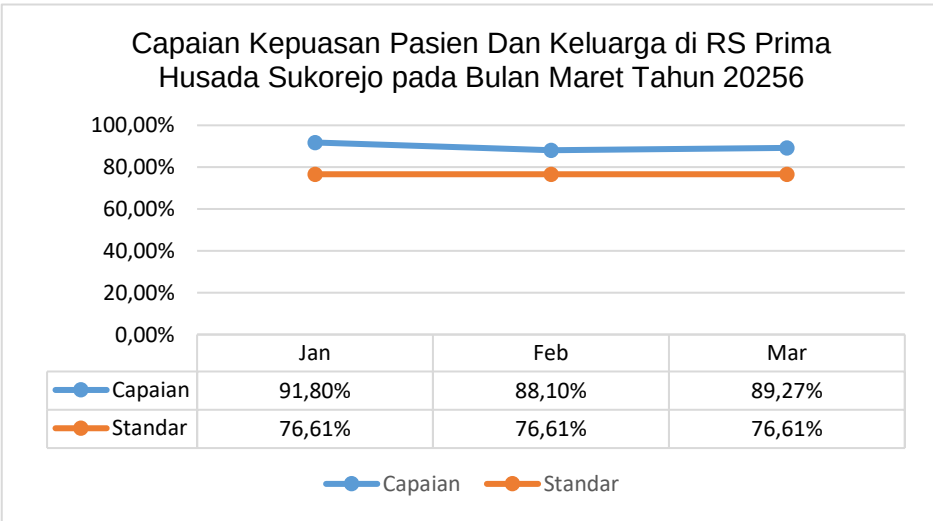


Gambar 3.12. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada Triwulan I Tahun 2026 yakni 96,96% dan sesuai standar yakni ≥80%. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.13. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2026 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 89,72%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%.

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit

Tabel 3.13 Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit pada Triwulan I Tahun 2026

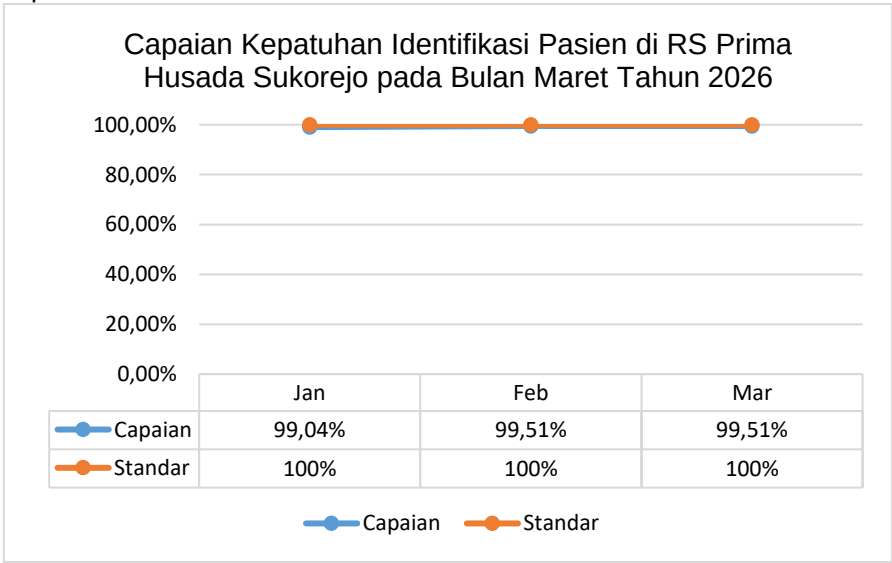
No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	1. Mengidentifikasi pasien dengan benar: a. Kepatuhan Identifikasi pasien	99,04%	99,51%	99,51%										100%	99,35%	PDSA
		2. Meningkatkan komunikasi yang efektif: a. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	98,06%	98,28%	97,35%										100%	97,89%	PDSA
		3. Meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai (<i>High Alert Medications</i>): a. Kepatuhan staf farmasi dalam penempelan stiker LASA dan High Alert	-	-											100%		
		4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur	-	-											100%		

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
		yang benar, pembedahan pada pasien yang benar: a. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien															
		5. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan: a. Kepatuhan Kebersihan Tangan	89,40%	91,13%	91,92%										85%	90,81%	Dipertahankan
		6. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh: a. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	98,02%	98,09%	98,04%										100%	98,05%	PDSA
2	Pelayanan Klinis Prioritas	1. Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planning pada pasien DM sebagai upaya mitigasi complain pasca rawat															Dipertahankan

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
		2. Kepatuhan PPK/CP DM Tipe 2 dengan Komplikasi															Dipertahankan
3	Renstra RS	1. Presentase Pasien Complain	0,17%	0,27%	0,16%										0%		Dipertahankan
4	Perbaikan Sistem	1. Waktu tunggu layanan farmasi obat jadi < 30 menit dan obat racikan < 60 menit	85,93%	84,17%	83%										≥80%	84,36%	Dipertahankan
		2. Waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit	75,56%	75%	70%										≥80%	73,52%	PDSA
5	Manajemen Resiko	1. Presentase berkas pending klaim	3,49%	3,81%	3,79%										<5%	3,69%	Dipertahankan
		2. Angka kerusakan alat medis karena ketidakpatuhan staf menjalankan SPO	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	1	PDSA

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

- 1. Analisis Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 - a. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.14. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I 2026 mencapai 99,53%. Dari 14254 petugas yang diobservasi ditemukan 14183 petugas yang patuh terhadap identifikasi pasien. Capaian ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan secara konsisten telah menerapkan standar keselamatan pasien, khususnya dalam hal identifikasi menggunakan dua identitas yang benar (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis), sebelum melakukan tindakan medis maupun keperawatan. Walaupun hasil tersebut masih belum mencapai nilai standar.

Tabel 3.14 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Triwulan I Tahun 2026

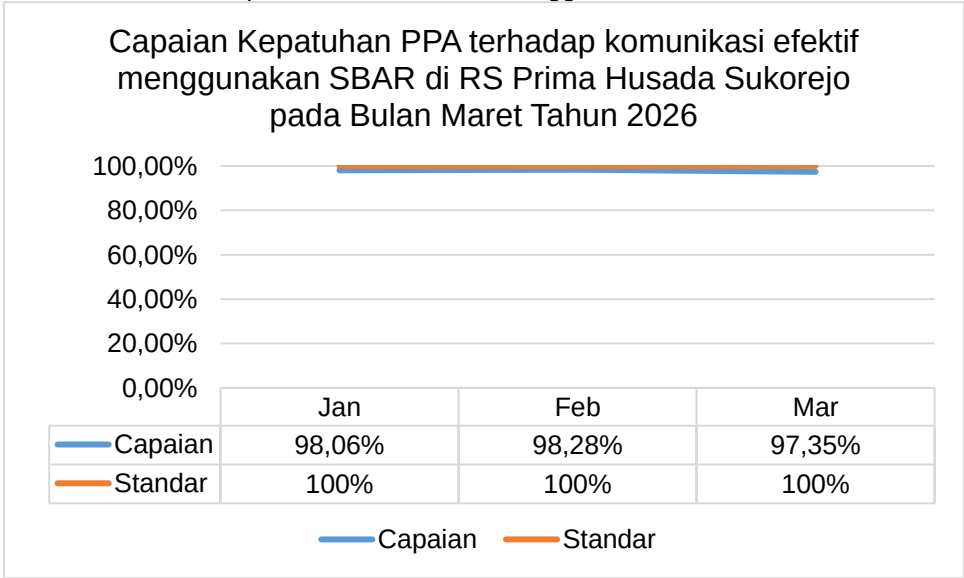
Problem	Meskipun capaian kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Triwulan I sangat tinggi (99,53%), masih ditemukan 66 petugas (0,47%) dari 14.254 observasi yang belum patuh. Ditemukan kegagalan telusur pada 66 observasi di mana petugas tidak melakukan pengecekan gelang identitas sebelum melakukan tindakan krusial seperti: a. Pemberian Injeksi (Analgesik/Obat lain) b. Pemberian Oksigenasi c. Pengambilan Sampling Darah d. Pemeriksaan Gula Darah (GDA) e. Monitoring TTV Hal ini menunjukkan adanya gap antara "bertanya nama" dengan "verifikasi identitas pada gelang", yang merupakan standar baku keselamatan pasien
Step	1. Mengidentifikasi data <i>by name</i> dan unit asal dari 66 petugas yang tidak melakukan verifikasi gelang untuk memetakan area dengan risiko tertinggi. 2. Menjadwalkan kehadiran perwakilan Komite PMKP pada rapat rutin bulanan di setiap unit pelayanan untuk diseminasi data.
Plan	1. Objective: Mencapai 100% verifikasi gelang pada setiap tindakan medis dan keperawatan. 2. Strategi: Mewajibkan ritual "Lihat, Baca, dan Cocokkan" sebelum menyentuh pasien untuk tindakan apa pun.
Do	1. Edukasi "On-the-Spot": Menegur langsung saat petugas terlihat hanya bertanya nama tanpa melihat gelang saat akan menyuntik atau mengambil darah
Study	1. Hasil Analisis: Petugas cenderung melewati cek gelang pada tindakan rutin (seperti monitoring TTV atau GDA) karena merasa tindakan tersebut "ringan", padahal kesalahan identitas pada TTV atau GDA tetap dapat mengakibatkan salah diagnosa dan salah terapi oleh dokter. 2. Tindakan seperti "Injeksi Analgesik" dan "Sampling Darah" adalah titik kritis yang paling berbahaya jika gelang tidak dicek.

Action	1. Perwakilan Komite PMKP akan menghadiri rapat rutin di setiap unit (Rawat Inap, IGD, IKO, dll). Tujuannya adalah memaparkan data ketidakpatuhan secara transparan dan membahas kendala spesifik di lapangan. 2. Petugas yang tidak melakukan cek gelang pada tindakan-tindakan tersebut diserahkan datanya (<i>by name</i>) kepada Kepala Unit untuk dilakukan pembinaan dan dimasukkan ke dalam penilaian evaluasi kinerja staf.
---------------	--

Tabel 3.15 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Perwakilan Komite PMKP akan menghadiri rapat rutin di setiap unit (Rawat Inap, IGD, IKO, dll). Tujuannya adalah memaparkan data ketidakpatuhan secara transparan dan membahas kendala spesifik di lapangan	Memaparkan data ketidakpatuhan secara transparan dan mengidentifikasi kendala spesifik di lapangan.	Kepala Unit dan seluruh staf klinis (Rawat Inap, IGD, IKO, dll)	Diseminasi Data Faktual: Menyajikan perbandingan data kepatuhan antar unit dan diskusi solusi atas kendala "tidak cek gelang".	Komite PMKP	1 bulan
2	Pembinaan individu dan evaluasi kinerja oleh Kepala Ruangan.	Meningkatkan kedisiplinan staf dan memastikan prosedur "Lihat, Baca, Cocokkan" dijalankan 100%.	Staf yang tidak patuh dalam observasi.	Kepala Ruangan memasukkan poin pelanggaran identifikasi ke dalam evaluasi kinerja staf.	Kepala Ruangan	Periode penilaian kinerja berjalan

b. Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR



Gambar 3.15. Capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Triwulan I Tahun 2026 yakni 97,89%. meskipun angkanya tergolong tinggi capainnya masih dibawah standar 100%. Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kasus

atau tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya menerapkan komunikasi efektif dengan metode SBAR.

Tabel 3.16 PDSA Capaian Kepatuhan Petugas terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Triwulan I Tahun 2026

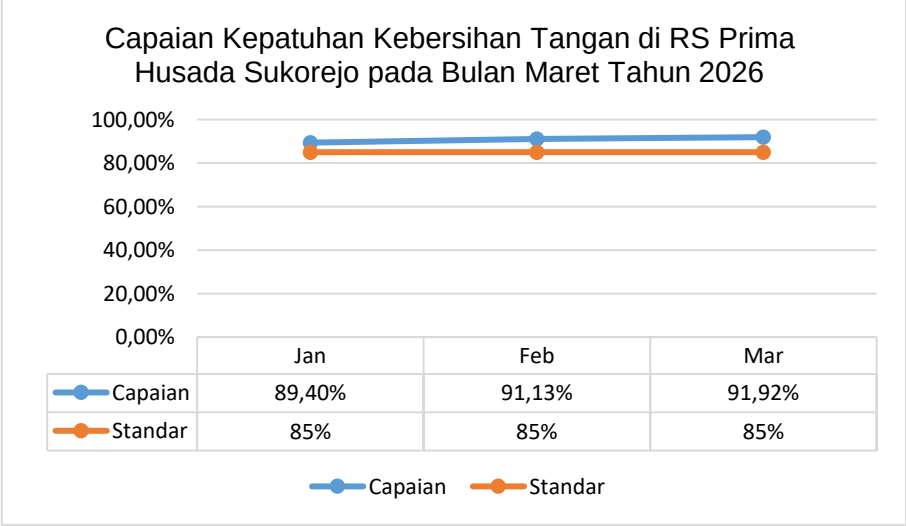
Problem	Capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif SBAR pada Triwulan I 2026 sebesar 97,89%, masih di bawah standar 100%. Dari 54 data tidak patuh, ditemukan masalah serius yaitu instruksi dokter via WhatsApp tidak dituangkan ke dalam form SBAR dan adanya form yang tidak ditandatangani oleh penerima pesan. Hal ini berisiko pada legalitas instruksi medis dan keselamatan pasien
Step	1. Audit Kepatuhan TBAK: Meninjau kembali prosedur Konfirmasi (TBAK: Tulis, Baca, Konfirmasi) khusus untuk instruksi via media sosial/pesan singkat (WA). 2. Review Rekam Medis: Mengidentifikasi unit-unit yang sering menerima <i>advice</i> via WA namun lalai mencatatnya di lembar SBAR terintegrasi.
Plan	1. Objective: Mencapai kepatuhan 100% dengan fokus pada pendokumentasian instruksi verbal/pesan singkat 2. Strategi: Memperketat pengawasan terhadap instruksi "Advice WA" agar wajib disalin ke form SBAR dalam waktu maksimal 1x24 jam dan ditandatangani.
Do	1. Edukasi Khusus: Mengingatkan PPA bahwa instruksi via WA tetap harus mengikuti prosedur SBAR/TBAK sebagai bukti legal di rekam medis. 2. Verifikasi Penerima: Mewajibkan kepala tim untuk mengecek kelengkapan TTD penerima pesan sebelum pergantian <i>shift</i> .
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada bulan Bulan Triwulan I Tahun 2026 yakni 97,89%. 2. Hasil Analisis: Ketidakpatuhan (2,11%) disebabkan oleh anggapan bahwa instruksi di WA sudah cukup kuat sebagai bukti, sehingga petugas malas/lupa menyalinnya ke rekam medis. 3. Temuan: Adanya kelalaian administratif berupa TTD yang tertinggal karena petugas terburu-buru melakukan tindakan setelah menerima instruksi.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan Bulan Triwulan I Tahun 2026 yakni 97,89%. Capaian 97,89% belum memenuhi standar minimal 100% karena masih ditemukan instruksi via WhatsApp yang tidak dilakukan SBAR dan ketiadaan TTD penerima pesan. Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Sosialisasi Prosedur "Advice WA": Menegaskan kembali bahwa instruksi melalui pesan singkat (WhatsApp) memiliki status yang sama dengan instruksi verbal, sehingga wajib dilakukan prosedur TBAK (Tulis, Baca, Konfirmasi) dan dicatat dalam rekam medis. 2. Audit Tanda Tangan Penerima: Mewajibkan Kepala Ruangan untuk melakukan <i>spot check</i> setiap akhir <i>shift</i> guna memastikan seluruh instruksi telepon/WA sudah ditandatangani oleh penerima pesan. 3. Pembinaan Personal "By Name": Memberikan edukasi lisan kepada 54 petugas yang teridentifikasi tidak patuh untuk memahami risiko hukum jika instruksi medis tidak terdokumentasi dengan lengkap.

Tabel 3.17 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Diseminasi Data & Sosialisasi TBAK Digital.	Memastikan PPA memahami bahwa instruksi WA harus disalin ke rekam medis (SBAR).	Seluruh Perawat, Bidan, dan Dokter.	Menekankan aspek legalitas rekam medis sebagai perlindungan hukum bagi PPA.	Komite PMKP	1 bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
2	Supervisi Kelengkapan Administrasi (TTD).	Menghilangkan <i>gap</i> administratif pada kolom tanda tangan penerima pesan.	Berkas Rekam Medis (Lembar SBAR/CPPT).	Melakukan kroscek antara grup koordinasi WA unit dengan catatan di rekam medis.	Kepala Ruangan	1 bulan
3	Monitoring Pasca-Intervensi.	Mengevaluasi efektivitas edukasi terhadap pencapaian target 100%.	Unit Pelayanan Rawat Inap & IGD	Membandingkan data kepatuhan SBAR bulan Triwulan I dengan Triwulan I 2026.	Tim Mutu	Akhir Triwulan I 2026

c. Kebersihan Tangan

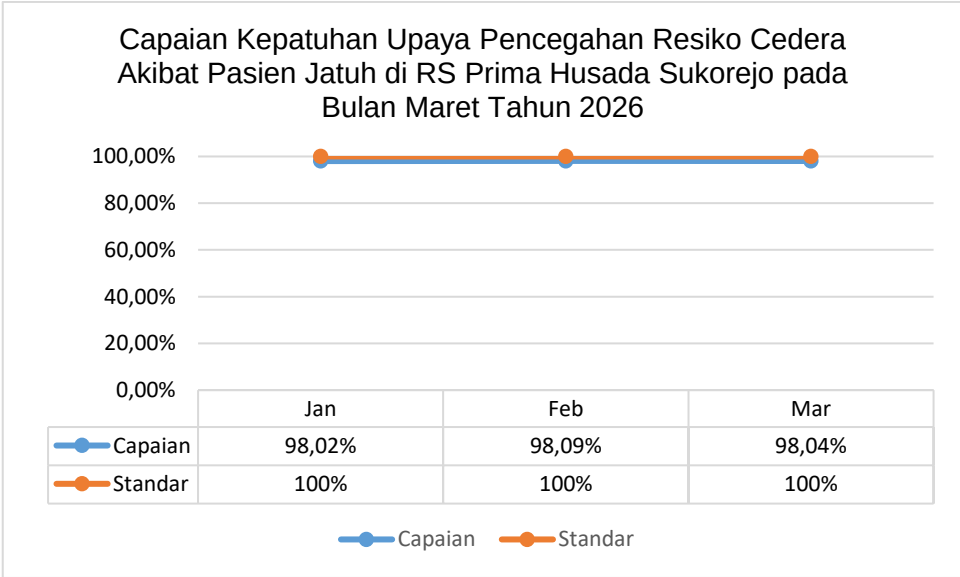


Gambar 3.16. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Bulan Triwulan I yakni mencapai 90,81%. Dari 3234 petugas yang diobservasi yang melakukan patuhan dengan benar yakni 2936 petugas. Capaian sebesar **90,81%** ini menandakan bahwa mayoritas besar petugas (2936 dari 3234 orang) telah menerapkan prosedur cuci tangan sesuai dengan protokol yang berlaku. Meskipun angka ini sudah berada di kategori tinggi, upaya monitoring tetap diperlukan untuk menjangkau sisa petugas yang belum konsisten dalam kepatuhan.

d. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh



Gambar 3.17. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Bulan Triwulan I tahun 2026 adalah 98,05%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 3744 pasien yang diobservasi, 3670 pasien dilakukan upaya pencegahan risiko jatuh secara benar

Tabel 3.18 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan pencegahan risiko pasien jatuh pada Triwulan I 2026 sebesar 98,05% , masih di bawah target mutlak 100% . Dari 3744 pasien, terdapat 74 pasien (1,95%) yang tidak mendapatkan perlindungan risiko jatuh secara standar. Berdasarkan audit visual, ditemukan: 1. Pasien risiko tinggi tidak ada tanda risiko jatuh di bed pasien. 2. <i>Handrail</i> tempat tidur tidak terpasang/terkunci. 3. Kurangnya edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pencegahan jatuh.
Step	1. Audit Logistik: Memastikan ketersediaan stok stiker risiko jatuh di setiap <i>nurse station</i>. 2. Pengecekan Fasilitas: Melakukan inspeksi terhadap kondisi <i>handrail</i> tempat tidur di seluruh ruang perawatan untuk memastikan fungsi kuncinya masih baik.
Plan	1. Objective: Mencapai tingkat kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh sebesar 100% pada periode audit berikutnya melalui penguatan pengawasan fasilitas dan edukasi keluarga. 2. Strategi: Optimalisasi Penandaan: Mewajibkan pemasangan tanda risiko jatuh pada tempat tidur segera setelah skor asesmen menunjukkan risiko tinggi.
Do	1. Pemasangan Atribut: Petugas wajib memasang stiker kuning di bed pasien segera setelah asesmen awal menunjukkan skor risiko tinggi. 2. Perawat memberikan edukasi singkat kepada keluarga pasien mengenai cara menjaga <i>handrail</i> tetap terpasang dan cara memanggil bantuan.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Ketidakpatuhan (1,95%) sering terjadi karena petugas lupa memasang tanda risiko jatuh saat pasien baru datang atau saat beban kerja tinggi. 2. <i>Handrail</i> yang tidak terpasang sering kali disebabkan oleh keluarga pasien yang menurunkannya dan perawat tidak segera mengecek ulang saat ronde.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Bulan Triwulan I Tahun 2026 belum sesuai standar yakni 98,05% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Rapat Koordinasi Unit: Memaparkan temuan 74 pasien tidak patuh tersebut dalam rapat unit sebagai pengingat risiko cedera kepala atau patah tulang jika pasien jatuh.

	2. Evaluasi Kinerja: Nama petugas yang bertanggung jawab pada 74 kasus ketidakpatuhan tersebut diserahkan kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam penilaian kinerja bulanan. 3. Redesign Monitoring: Mewajibkan pengecekan <i>handrail</i> menjadi bagian dari <i>checklist</i> operan perawat setiap pergantian <i>shift</i>.
--	---

Tabel 3.19 Rencana Tindak Lanjut

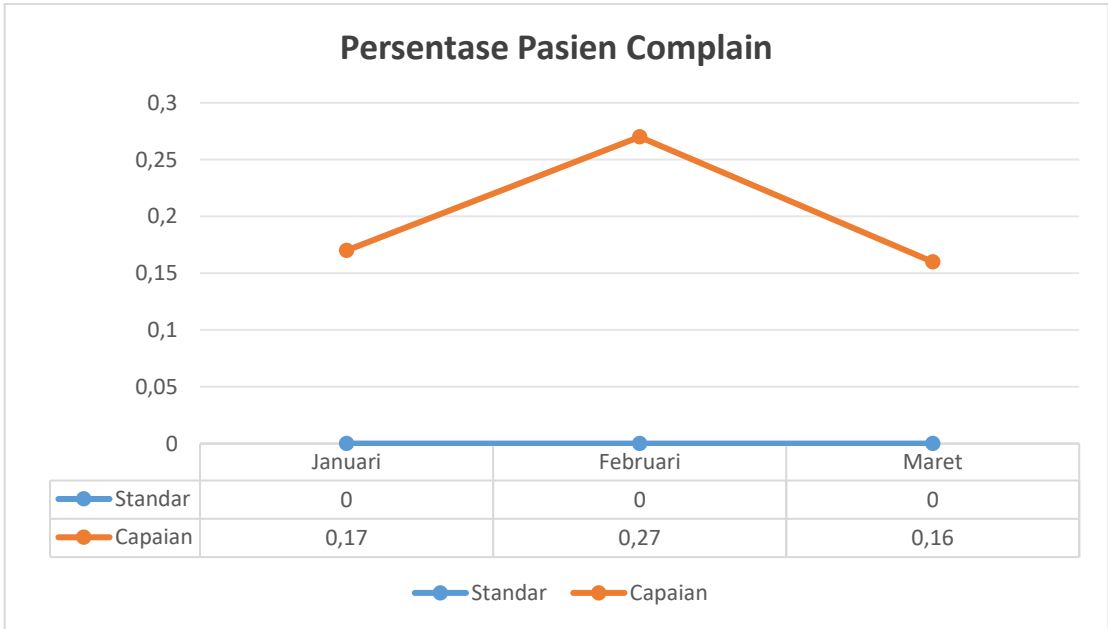
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rapat Koordinasi Unit	Meningkatkan kesadaran staf mengenai urgensi pencegahan cedera (patah tulang/cedera kepala) akibat jatuh.	Seluruh staf klinis di unit rawat inap.	Memaparkan data 74 pasien tidak patuh secara transparan sebagai bahan evaluasi dan penguat risiko klinis.	Komite PMKP	1 bulan
2	Evaluasi Kinerja dan Pembinaan Personal.	Memastikan akuntabilitas staf dalam menjalankan standar prosedur keselamatan pasien.	74 Petugas yang teridentifikasi tidak patuh.	Performance Integration: Menyerahkan data <i>by name</i> kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam poin penilaian kinerja bulanan.	Kepala Ruangan	1 bulan
3	<i>Redesign Monitoring</i> melalui <i>Checklist</i> Operan.	Menjamin fasilitas keamanan (<i>handrail</i>) dan tanda risiko selalu terpasang di setiap pergantian <i>shift</i> .	Fasilitas tempat tidur pasien risiko tinggi.	Mewajibkan pengecekan fisik <i>handrail</i> dan stiker sebagai item wajib dalam <i>bedside handover</i> (operan di samping bed).	Perawat Pelaksana & Karu	1 bulan

2. Analisis Capaian Indikator Pelayanan Klinis Prioritas
- a. Tingkat Kesesuaian Ukuran Tumor dengan Hasil PA

b. Kepatuhan PPK/CP Tumor Jaringan Lunak

c. Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planning pada pasien DM sebagai upaya mitigasi komplain pasca rawat

d. Kepatuhan PPK/CP DM Tipe 2 dengan Komplikasi
3. Analisis Capaian Indikator Rencana Strategis RS
- a. Presentase Pasien Complain



Gambar 3.18. Capaian Persentase Pasien Complain di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisa :
Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian persentase pasien complain pada Triwulan I tahun 2026 adalah 0,2%, angka tersebut belum mencapai target 0% complain. Dari 34.945 pasien yang diobservasi, sejumlah 59 pasien mengadakan complain terkait pelayanan yang diperoleh.

Tabel 3.20 PDSA Capaian Persentase Pasien Complain pada Tahun 2026

Problem	Capaian persentase pasien komplain pada Triwulan I 2026 sebesar 0,2% masih ada celah yang menunjukkan pasien berkesempatan untuk mengadakan komplain selama atau setelah mendapatkan pelayanan. Dari 34.945 pasien, terdapat 59 pasien (0,2%) yang melakukan pengaduan terkait pelayanan yang telah diterima. Berdasarkan telaah umum, ditemukan komplain ditujukan pada : - Respon yang lama dari petugas saat pasien ada keluhan - Pelayanandan/atau antrean yang lama - Sikap dan/atau tingkah laku staf yang dianggap tidak sopan
Step	Analisis data Komplain : Melakukan analisis terhadap seluruh komplain yang masuk untuk dapat memetakan unit yang paling sering mendapatkan komplain Menentukan Prioritas : Memastikan MOD tanggap dalam merespon setiap komplain sesuai dengan grading sehingga komplain dapat ditelusur dan diselesaikan
Plan	Objective: Mencapai prosentase pasien komplain sebesar 0% pada periode audit berikutnya melalui telusur optimal dan efektif Strategi: Telusur optimal dan efektif melalui komunikasi dengan pasien untuk kemudian mengkonfirmasi pada unit atau staf terkait sehingga kejadian tidak terulang ataupun tertanggulangi.
Do	Respon Komplain : MOD dan Humas sebagai garda terdepan yang berhubungan dengan pasien, sehingga ketika ada komplain dapat dikategorikan, ditelusur, konfirmasi dan memberikan solusi cepat Kolaborasi : Merangkul staf untuk melakukan perbaikan sehingga komplain tidak terulang serta melakukan konsultasi segera ketika komplain yang ditujukan berdampak besar pada kehidupan rumah sakit
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? - MOD memberikan tanggapan sesuai dengan kategori urgensi disertai dengan telusur, meski telah dilakukan penelusuran segera dan pemberian TL tetapi masih ada komplain dari pasien, dari Bulan Februari ke Bulan Maret ditemukan penurunan persentase namun komplain masih ada - MOD masih terkendala untuk menemukan akar masalah karena komplain yang disampaikan tidak spesifik sehingga masalah belum sampai pada tahap tindak lanjut

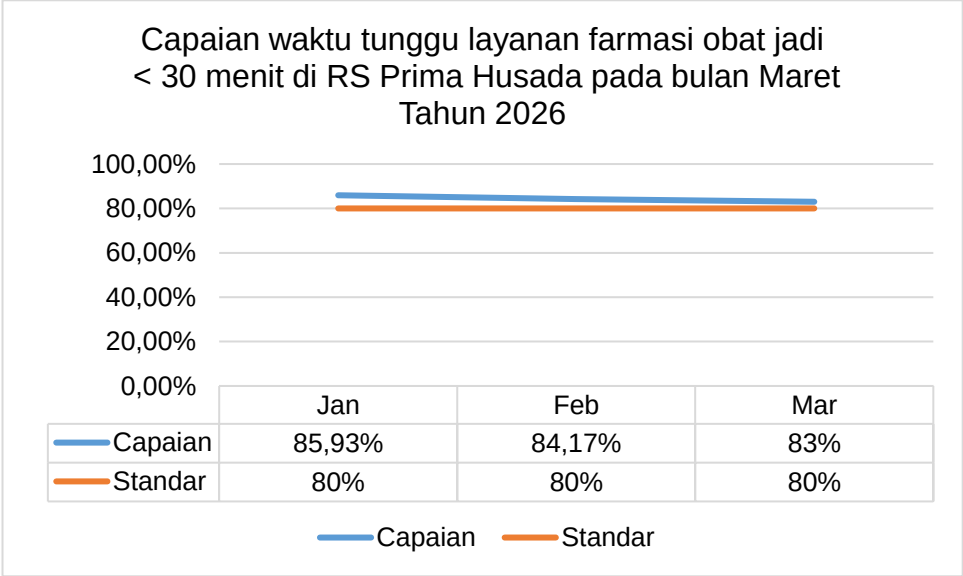
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian persentase pasien komplain pada Triwulan I Tahun 2026 belum sesuai standar yakni 0,2% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Rapat Koordinasi Unit: Memaparkan kepada unit bahwa masih ditemukan komplain dari pasien sebanyak 59 pengaduan yang beragam dari berbagai aspek. Koordinasi dengan seluruh unit untuk selalu memberikan edukasi pada setiap kegiatan yang beresiko komplain. 2. Evaluasi Kinerja: Nama petugas yang bersinggungan atau diorientasikan pada 59 komplain tersebut diserahkan kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam penilaian kinerja bulanan ketika tidak terjadi perubahan dalam kurun waktu yang telah disepakati. 3. Redesign Monitoring: Mewajibkan petugas untuk mengutamakan keramahan, responsif dan empati pada pasien saat melakukan perawatan maupun pelayanan.
---------------	--

Tabel 3.21 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rapat Koordinasi Unit	Meningkatkan kesadaran staf terkait efek yang dihasilkan dari komplain yang tidak tertangani atau berulang di unit kerja.	Seluruh staf	Memaparkan kepada unit bahwa masih ditemukan komplain dari pasien sebanyak 59 pengaduan yang beragam dari berbagai aspek. Koordinasi dengan seluruh unit untuk selalu memberikan edukasi pada setiap kegiatan yang beresiko komplain	Komite PMKP	1 bulan
2	Evaluasi Kinerja dan Pembinaan Personal.	Memastikan akuntabilitas staf dalam menjalankan pelayanan.	Seluruh staf	Performance Integration: Menyerahkan data <i>by name</i> kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam poin penilaian kinerja bulanan ketika ditemukan tidak ada perubahan dari sikap profesionalitas staf saat bertugas.	Kepala Ruangan	1 bulan
3	<i>Redesign Monitoring</i> melalui <i>Checklist</i> Operan.	Memastikan seluruh staf dapat mengutamakan kepuasan pasien saat pelayanan.	Seluruh staf pelayanan	Mewajibkan petugas untuk mengutamakan keramahan, responsif dan empati pada pasien saat melakukan perawatan maupun pelayanan.	Kepala Ruang	1 bulan

4. Analisis Capaian Indikator Perbaikan Sistem

a. Waktu tunggu layanan farmasi obat jadi < 30 menit

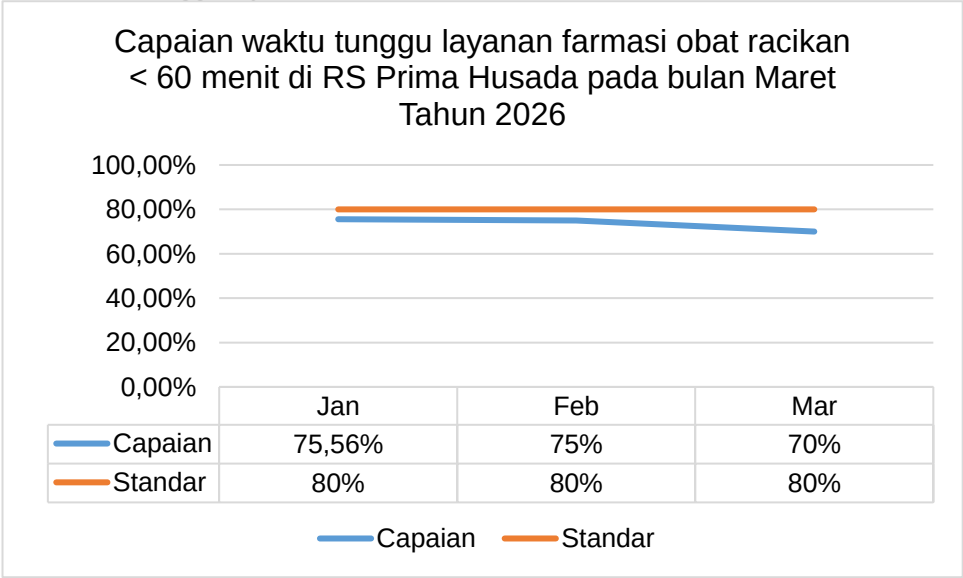


Gambar 3.19. Capaian Persentase Pasien Complain di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian waktu tunggu layanan farmasi obat jadi < 30 menit pada Triwulan I pada tahun 2026 adalah 84,36%. Angka tersebut telah mencapai target 80%. Dari 375 resep yang diobservasi, 316 resep yang selesai < 30 menit.

b. Waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit



Gambar 3.20. Capaian Persentase Pasien Complain di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit pada Triwulan I pada Tahun 2026 adalah 73,52%. Angka tersebut belum mencapai target 80%. Dari 375 resep yang diobservasi, 275 resep yang selesai < 60 menit.

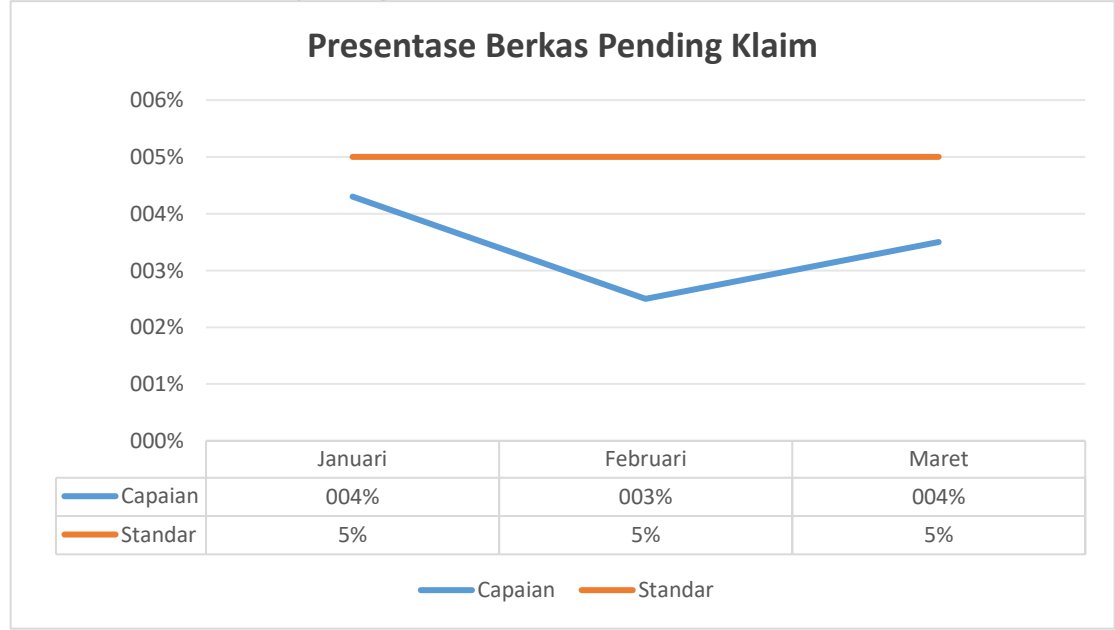
Tabel 3.22 PDSA Capaian Waktu Tunggu Obat Racikan < 60 Menit pada Tahun 2026

Problem	Capaian waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit pada bulan Maret 2026 sebesar 70%, masih di bawah target 80%. Dari 120 resep, terdapat 36 resep (30%) yang selesai > 60 menit
Step	1. Analisis Beban Kerja: Menghitung jumlah resep per petugas di jam sibuk

	2. Observasi Alur (<i>Time Motion Study</i>): Mengamati di tahap mana (pengetikan, menumbuk, atau mengemas) yang paling lambat 3. Wawancara Staf: Mencari tahu kendala teknis yang dirasakan petugas
Plan	1. Memisahkan alur pelayanan resep racikan dan non racikan 2. Menyediakan petugas khusus peracikan pada jam sibuk 3. Menyiapkan bahan dan kemasan racikan yang sering digunakan 4. Menggunakan sistem antrian dan pencatatan waktu (mulai–selesai) 5. Menginformasikan estimasi waktu tunggu kepada pasien 6. Melakukan briefing harian terkait pembagian tugas
Do	1. Melaksanakan pemisahan alur pelayanan racikan 2. Menugaskan petugas khusus racikan pada jam puncak. 3. Mencatat waktu penerimaan resep dan waktu penyerahan obat 4. Menyediakan bahan racikan yang sering digunakan di area peracikan 5. Memberikan edukasi kepada pasien mengenai estimasi waktu tunggu
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Capaian waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit pada bulan Maret 2026 sebesar 70%, masih di bawah target 80%. 2. Penyebab belum tercapainya target waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit pada bulan Maret 2026 adalah adalah penumpukan antrean di satu meja peracikan yang sama dengan obat non-racikan
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Mengusulkan penambahan SDM pada jam sibuk 2. Mengembangkan sistem elektronik monitoring waktu tunggu 3. Melakukan pelatihan efisiensi teknik peracikan 4. Menyusun daftar (formularium) obat racikan standar yang bisa disiapkan lebih awal (pre-compounding) sesuai regulasi 5. Mengoptimalkan manajemen beban kerja dan jadwal petugas

5. Analisis Capaian Indikator Manajemen Resiko

a. Presentase berkas pending klaim

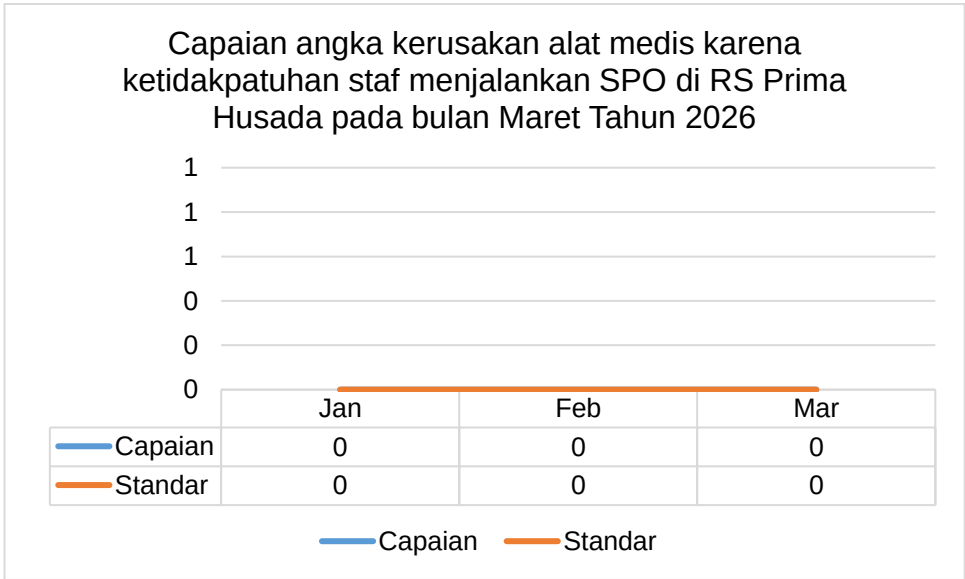


Gambar 3.21. Capaian Persentase Berkas Pending Klaim di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian persentase berkas pending klaim pada Triwulan I pada Tahun 2026 adalah 3,69%. Angka tersebut sudah mencapai target <5%. Dari 25627 berkas yang diklaimkan, terdapat 945 berkas yang pending.

b. Angka kerusakan alat medis karena ketidakpatuhan staf menjalankan SPO



Gambar 3.22. Capaian Angka Kerusakan Alat Medis Karena Ketidakpatuhan Staf Menjalankan SPO di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Maret Tahun

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata angka kerusakan alat medis karena ketidakpatuhan staf menjalankan SPO pada Bulan Maret tahun 2026 adalah 0. Angka tersebut telah mencapai target 0 kejadian.

3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit

1. INSTALASI GAWAT DARURAT

Tabel 3.23 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Gawat Darurat pada Triwulan I Tahun 2026

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	100%	100%										≥ 85 %	100%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien	98,21%	98,79%	98,25%										≥ 76,61 %	98,41%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	94,98%										100%	98,32%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	99,36%	100%	100%										100%	99,78%	PDSA

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Instalasi Gawat Darurat <5 menit setelah pasien datang	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2	Kematian pasien< 24 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0,01%	0%	0,04%										≤ 0,24%	0,01%	Dipertahankan
3	Kelengkapan pengisian pengkajian medis E-Rm.	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
4	Kelengkapan pengisian pengkajian keperawatan E-Rm.	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
5	Kelengkapan pengisian LOP	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
6	Kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
7	Waktu Tunggu Pemasangan Gelang Identitas pasien dari pasien	93,55%	100%	100%										100%	97,85%	PDSA

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	mendaftar sampai terpasang di pasien < 15 menit															
8	Respon time pengantaran pasien P2 & P3 ke Rawat Inap < 3 jam	95,48%	100%	100%										100%	98,49%	PDSA

2. INSTALASI RAWAT JALAN

Tabel 3.24 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Jalan pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	87,69%	90,41%										≥ 85 %	92,70%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	77,60%	70,48%	76,42%										100%	74,83%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	50%	100%										≥ 76,61%	83,33%	
5	Waktu tunggu rawat jalan	98,12%	85,61%	75,83%										≥ 80%	86,52%	Dipertahankan
6	Kepatuhan Penggunaan	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

	Alat Pelindung Diri															
Indikator Mutu Prioritas RS																
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan $\geq$ 30 menit	32,70%	4%	20%										0%	18,90%	PDSA
2.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal medis E-RM pasien rawat jalan	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
3.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal keperawatan E-RM pasien rawat jalan	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A

Tabel 3.25 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2A pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	96,67%	97,39%	97,50%										100%	91,18%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	87,58%	85,61%	82,58%										≥ 85 %	85,25%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan	94,17%	96,52%	96,67%										100%	95,78%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	resiko pasien jatuh															
4	Kepuasan pasien	100%	91,84%	92,50%										≥ 76,61 %	94,78%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	79,34%	80,17%	81,67%										≥ 80%	80,39%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi										≥ 80%		Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	82,14%	100%										100%	94,04%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	95,83%	95,95%	95,83%										100%	95,87%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	2,27%	0,63%	1,21%										≤ 0,24 %	1,37%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	3 kejadian	2 kejadian	2 kejadian										0 kejadian	3 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	Pasien tidak sesuai															
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≥24 Jam	94,21%	95,69%											100%		PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	95,83%	96,55%											100%		PDSA

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B

Tabel 3.26 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2B pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,71%	95%	100%										100%	97,90%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	88,54%	88,33%	89,36%										≥ 85 %	88,74%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	96,13%	95%	98,71%										100%	96,61%	PDSA
4	Kepuasan pasien	88,89%	83,54%	87,27%										≥ 76,61 %	86,57%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	53,55%	60%	60,65%										≥ 80%	58,07%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi										≥ 80%	Tidak ada	
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	82,35%										100%	94,12%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,75%	2,13%	1,52%										≤ 0,24 %	1,47%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	4 kejadian	6 kejadian	2 kejadian										0 kejadian	4 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	2 kejadian	4 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	2 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian	85,81%	93,57%	86,45%										100%	88,61%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam															
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	97,42%	97,14%	97,42%										100%	97,33%	PDSA

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A

Tabel 3.27 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3A pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,71%	98,57%	99,35%										100%	98,87%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	80%	86,96%	95,71%										≥ 85 %	87,55%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	98,06%	97,86%	98,06%										100%	97,99%	PDSA
4	Kepuasan pasien	(Tidak ada pasien yang mengisi barcode kepuasan pasien)	94,12%	100%										≥ 76,61 %	97,06%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	83,87%	91,43%	87,10%										≥ 80%	87,46%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	93,75%	Tidak diisi	Tidak diisi										≥ 80%		Dipertahankan
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	86,96%	100%	97,22%										100%	94,72%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	98,06%	98,57%	98,06%										100%	98,23%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0%	0%	0%										≤ 0.24 %	0%	Dipertahankan
2.	Kejadian pulang paksa	5 kejadian	3 kejadian	5 kejadian										0 kejadian	5 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal	98,06%	97,14%	97,42%										100%	97,54%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	medis oleh DPJP ≤24 Jam															
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

6. INSTALASI RAWAT INAP 3B

Tabel 3.28 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3B pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	90%	90%	90%										100%	90%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	85,96%	74,07%	87,10%										≥ 85 %	82,37%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	94,07%	92%	87,50%										100%	91,19%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	100%	100%										≥ 76,61 %	100%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	45,97%	55%	54,55%										≥ 80%	51,84%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Tidak ada pengisian CP	Tidak ada pengisian CP	Tidak ada pengisian CP										≥ 80%		

7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	97,44%	88,46%	96,97%										100%	94,29%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	90,83%	92%	90%										100%	90,94%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,5%	0,75%	0,01%										≤ 0.24 %	0,42%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	2 Kejadian	0 kejadian	1 kejadian										0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	66,92%	84%	84,17%										100%	78,36%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	89,17%	88%	88,33%										100%	88,50%	PDSA

7. INSTALASI KAMAR OPERASI

A. Bedah

Tabel 3.29 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Bedah pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	83,87%	91,23%	100%										≥ 85 %	91,70%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
4	Penundaan operasi elektif ≥ 60 menit	2,14%	1,28%	1,14%										≤ 5%	1,52%	Dipertahankan
5	Kepuasan pasien													≥ 76,61 %		Dipertahankan
6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan pelaksanaan <i>surgical safety checklist</i> sesuai standart	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2	Kejadian tidak dilakukannya	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	penandaan pada pasien operasi															
3	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor													≥ 90 %		Dipertahankan
4	Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	1 kejadian	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO	100%	100%	99,46%										100%	99,82%	Dipertahankan
2	Angka kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
3.	Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
5.	Kejadian Kematian di meja Operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Kejadian operasi salah sisi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7.	Kejadian operasi salah orang	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
8.	Kejadian salah tindakan pada operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9.	Kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

B. Anestesi

Tabel 3.30 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Anestesi pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kejadian reaksi anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3	Kejadian salah penempatan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi	0 kejadian	2 kejadian	2 kejadian										0 kejadian	2 kejadian	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
6	Angka efek samping selama sedasi moderat	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

8. MATERNITAS

Tabel 3.31 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Maternitas pada Triwulan I Tahun 2026

Lampiran 3.01 Capaian Indikator Mutu Nasional Unit Maternitas pada Trivulan I Tahun 2020																
No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,56%	93,55%										100%	96,37%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	94,83%	97,37%	93,10%										≥ 85 %	95,10%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	97,85%	100%	100%										100%	99,28%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
5	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	50%	60%	50%										> 80%	53,33%	PDSA
6	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	75,89%	76,85%	83,72%										≥ 80%	78,82%	PDSA
7	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	100%	100%	100%										≥ 80%	100%	Dipertahankan
8	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%										≥ 76,61 %	100%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian pasien Preeklamsia yang mengalami perburukan menjadi eklamsi	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian										0 kejadian	1 kejadian	PDSA
2	Kejadian pasien dengan Eklamsia yang	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	dilahirkan dalam waktu > 12 jam															
3	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh Eklampsia	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian kematian ibu karena HPP	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian kematian ibu persalinan karena sepsis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kepatuhan pemberian kortikosteroid pada persalinan premature	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

9. PONEK

Tabel 3.32 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PONEK pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			

Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
3	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	94,44%	100%	94,44%										> 80%	96,29%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	100%	100%	Tidak ada yang mengisi survei										≥ 76,61 %	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	100%	100%	100%										100%	100%	Tidak ada pasien HPP di Ponok
2	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit yang dilakukan	100%	100%	100%										100%	100%	dipertahankan

	oleh Tim ponek yang terlatih															
3	Persentase Ibu bersalin yang dilakukan skrining penilaian kegawatan/ severitas saat masuk ke Fasyankes	100%	100%	100%										100%	100%	dipertahankan

10. NEONATOLOGI

Tabel 3.33 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Neonatologi pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	95,70%	87,50%	93,94%										≥ 85%	92,38%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	95%										100%	98,33%	PDSA
5	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	70,97%	77,01%	63,83%										≥ 80%	70,60%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-										≥ 80%		Tidak ada pasien dengan Diagnosa tunggal

7	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%										≥ 76,61%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir	8 Kejadian	9 kejadian	7 kejadian										0 kejadian	8 kejadian	PDSA
2	Kepatuhan petugas dalam melakukan tindakan Ventilasi Tekanan positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit)	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
3	Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-piece resuscitator/CPAP dalam waktu 2 menit	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
4	Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500- 2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kanguru	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

	minimal 1 jam per hari															
5	Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotik pada BBL infeksi	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
6	Kejadian kematian bayi di Rumah Sakit	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	1 kejadian	PDSA
7	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

11. ICU
A. ICU

Tabel 3.34 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	89,29%	96,43%	96,77%										≥ 85%	94,16%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	30,77%	52,50%	34,38%										≥ 80%	39,21%	PDSA
5	Kepatuhan Penggunaan	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	Alat Pelindung Diri															
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Angka pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	50%	0%										≤ 3 %	16,66%	PDSA
2.	Kepatuhan pengisian pengkajian form kriteria keluar masuk ICU pada pasien ICU	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

B. ICU ISOLASI

Tabel 3.35 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU Isolasi pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien										100%		

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
2	Kepatuhan kebersihan tangan	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien										≥ 85%		
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien										100%		
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien										≥ 80%		
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien										100%		
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kepatuhan Waktu Pelayanan dokter di ICU isolasi (≤ 30 menit)	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien										≥ 80%		
2.	Kepatuhan Pembersihan dan desinfeksi ruangan	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien										≥ 95%		

12. RADIOLOGI

Tabel 3.36 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Radiologi pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi										100%		PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	100%	78,57%										≥ 85%		PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi										100%		PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	resiko pasien jatuh															
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%										100%		Dipertahankan
5	Kepuasan pasien	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi										≥ 76,61%		
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1 jam	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi										100%		PDSA
2.	Complain DPJP atas pembacaan hasil radiologi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi										0%		PDSA
3.	Angka ketidaklengkapan form permintaan radiologi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi										0%		PDSA
4.	kejadian kesalahan cetak hasil radiologi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi										0 kejadian		PDSA

13. LABORATORIUM

Tabel 3.37 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laboratorium pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	84,62%	98,04%	90,74%										≥ 85%	91,13%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	69,23%	77,42%	89,53%										100%	78,72%	PDSA
4	Kepuasan pasien													≥76,61%		
5	Pelaporan nilai kritis ≤30 menit	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2	kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3	Angka Kerusakan Sampel Darah	0,02%	0%	0%										0%	0,007%	PDSA
4	Angka ketidaklengkapan form permintaan laboratorium	3,95%	4,37%	2,83%										0%	3,71%	PDSA
5	Kejadian Kesalahan Pemindahan Hasil Laboratorium ke SIMRS	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	1 kejadian	PDSA
6	Kejadian Ketidaktepatan Waktu Pemeliharaan Alat KSO	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
7	Kejadian Keterlambatan Backup Alat Error Dalam Waktu 1x24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian Keterlambatan Hasil Laboratorium CITO ≥ 30 menit	0 kejadian	7 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	3 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian Keterlambatan Penyerahan labu darah > 1 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse	100%	97,87%	100%										100%	99,29%	Dipertahankan
11	Angka Reaksi Tranfusi Darah	0%	1,01%	0%										< 0,01%	0,337%	Dipertahankan
12	Kejadian ED labu darah	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan

14. REHAB MEDIS

Tabel 3.38 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rehab Medis pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	87,69%	100%										≥ 85%	95,90%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	0%	0%	0%										≥ 76,61%	0%	Belum ada pasien yang scan barcode
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan Tindakan fisioterapi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kelengkapan pengisian pengajian medis & protokol pasien rehab medik	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
3	Kelengkapan pengisian pengkajian fisioterapi	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	pasien rehab medik															
4	Kepatuhan pengisian pengkajian reassesment setiap 2 minggu & akhir terapi													100%		Dipertahankan

15. FARMASI

Tabel 3.39 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Farmasi pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	91,94%	89,80%	90,32%										≥ 85%	90,68%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien													≥ 76,61 %		Belum diisi
5	Penulisan resep sesuai formularium	100%	95%	87,83%										100%	94,27%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	waktu tunggu	85,93%	84,17%	81,67%										≥80%	83,92%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	pelayanan obat jadi ≤ 30 menit															
2	waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit	75,56%	75%	84,17%										≥80%	78,24%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
3	Kejadian kesalahan pernberian obat	0 kejadian	6 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	2 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi	2 kejadian	1 kejadian	5 kejadian										0 Kejadian	3 kejadian	PDSA
5	Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian perubahan pemberian obat profilaksis menjadi teraupetik													0 kejadian		PDSA

16. GIZI

Tabel 3.40 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	95,56%	100%	93,33%										≥ 85%	96,29%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	97,78%	88,89%	92,06%										100%	92,91%	PDSA
4	Kepuasan Pasien	91,80%												≥ 76,61%		Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100%	100%										≥ 90 %	100%	Dipertahankan
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	16%	16%	15%										≤ 20 %	15,66%	Dipertahankan
3	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Angka kelengkapan pengisian asuhan gizi pasien rawat inap	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
5	Kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Tersedianya air panas di tempat cucian alat dapur dengan standar 70 derajat	0%	0%	0%										100%	0%	PDSA

17. REKAM MEDIS

Tabel 3.41 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rekam Medis pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepuasan Pasien	91,80%	-	-										76,61%		Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	96,03%	95,80%	98,45%										100 %	96,76%	PDSA
2	Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan	33,33%	65%	97,42%										100 %	65,25%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	informasi yang jelas															
3	Kejadian Nomor Rekam Medis Ganda	3 kejadian	2 kejadian	1 kejadian										0 kejadian	2 kejadian	PDSA
4	Kejadian SEP tidak diterbitkan	1 kejadian	2 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
5	Kelengkapan RM pasien rawat inap (nama, TTD, jam, tgl)	96,77%	96%	96%										100%	96,25%	PDSA
6	Angka keterlambatan pengembalian DRM Pasien umum dan asuransi > 1x24 jam	33,90%	37,66%	43,06%										0%	38,20%	PDSA
7	Kelengkapan NIK di data pasien	97,19%	97,19%	96,83%										100%	97,07%	PDSA
8	Kelengkapan General Concent	99,35%	100%	99%										100%	99,45%	PDSA
9	Kelengkapan berkas E-RM IGD	19,35%	21,43%	23,70%										100%	21,49%	PDSA
10	Ketepatan laporan dengan pihak eksternal	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

18. LIMBAH – K3RS

Tabel 3.42 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Limbah-K3RS pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Baku mutu limbah cair	a.BOD =10,06 mg/l b. COD = 30,56 mg/l c. TSS = 5,40 mg/l d. PH =8,64 e. Faecal coli = 270	a.BOD =7,2 mg/l b. COD = 24,38 mg/l c. TSS = 5,40 mg/l d. PH =8,17 e. Faecal coli = 220	a.BOD =10,07 mg/l b. COD = 44,59 mg/l c. TSS = 5,40 mg/l d. PH =6,72 e. Faecal coli = 120										a.BOD < 12 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9 e. Faecal coli < 200	BOD =9,11 mg/l b. COD = 33,17 mg/l c. TSS = 5,40 mg/l d. PH =7,84 e. Faecal coli = 203,33	PDSA
2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%										100 %	100%	Dipertahankan
3.	Angka kepatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	0%	0%	0%										100%	0%	1 Tahun
4.	Kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian										0 kejadian	1 kejadian	PDSA

19. SDM

Tabel 3.43 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit SDM pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staf	0%	0%	5,97%										100 %	1,99%	PDSA
2.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	0%	0%	0%										≥ 60 %	0%	1 Tahun
3.	Angka turn over staf	2,38%	1,50%	0,64%										≤10% / bulan	1,51%	Dipertahankan
4.	Angka keterlambatan staf ≥10 menit	25,11%	20,13%	31,12%										0%	25,45%	PDSA
5.	Angka staff tersertifikasi khusus a. IGD : BLS/PPGD/GELS/ALS b. PONEK : PPGD c. ICU d. HD e. IKO f. Hiperkes g. NICU/PICU	69,41%	69,41%	69,41%										100%	69,41%	PDSA
6.	Kepuasan karyawan													≥ 80 %		semesteran
No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staf	0%	0%											100 %		PDSA
2.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	0%	0%											≥ 60 %		1 Tahun
3.	Angka turn over staf	2,38%	1,50%											≤10% / bulan		Dipertahankan
4.	Angka keterlambatan staf ≥10 menit	25,11%												0%		PDSA

5.	Angka staff tersertifikasi khusus a. IGD : BLS/PPGD/GELS/ALS b. PONEK : PPGD c. ICU d. HD e. IKO f. Hiperkes g. NICU/PICU	69,41%	69,41%												100%		PDSA
6.	Kepuasan karyawan														≥ 80 %		semesteran

20. KESEKRETARIATAN

Tabel 3.44 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kesekretariatan pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Ketepatan Pengumpulan UMANDOK 1 X 24 jam setelah selesai kegiatan	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2.	Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan unit ke sekretariatan	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
3.	Ketepatan pendistribusian surat masuk	100%	100%	98,39%										100%	99,46%	PDSA
4.	Ketepatan pendistribusian surat keluar	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

21. DRIVER

Tabel 3.45 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Driver pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan waktu pengantaran penggunaan ambulance < 30 menit	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pelaksanaan dekontaminasi ambulance	100%	100%	100%										≥80%	100%	Dipertahankan
3.	Response time driver ambulance < 5 menit	99,05%	100%	100%										100%	99,68%	PDSA

22. PEMULASARAAN JENAZAH

Tabel 3.46 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Pemulasaran Jenazah pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pendokumentasian pemulasaraan jenazah	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

23. ATEM – IPSRS

Tabel 3.47 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ATEM – IPSRS pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
ATEM																
1.	Waktu tanggap kerusakan alat medis non critical 1x24 jam	100%	100%	100%										≥80%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap kerusakan alat medis critical ≤ 15 menit	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
4.	Ketepatan kalibrasi alat sesuai dengan jadwal	-	-	100%										100%	100%	Alat di Kalibrasi di Bulan September
IPSRs																
1.	Waktu pelayanan perbaikan alat non medis ≤ 24 jam	95,71%	100%	100%										≥80%	98,57%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap kesiapan fungsi alat genset ≤ 10 detik	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
3.	Ketepatan Uji Coba Alat Genset (1 bulan sekali)	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

24. LAUNDRY

Tabel 3.48 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan penggunaan APD	83,33%	85,71%	50%										100%	73,01%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kejadian linen yang hilang	3 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
2.	Kejadian terdapat benda asing di linen	3 Kejadian	3 kejadian	4 kejadian										0 kejadian	4 kejadian	PDSA

25. CSSD

Tabel 3.49 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan staf CSSD dalam menggunakan APD di area dekontaminasi	91,34%	93,48%	100%										100%	94,94%	Dipertahankan
2.	Kejadian kertas steam indicator tidak berubah sesuai standar	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian										0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan waktu	97,47%	90,27%	94,90%										100%	94,21%	PDSA (IGD, Poli, IRNA 2A)

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	pengembalian instrumen dari user ke CSSD dalam bentuk rendaman															
4.	Kepatuhan hasil biological test negative pada BMHP reuse: 1. Breathing circuit 2. Begging 3. LMA 4. JR	-	-	-										100%	-	Hasil Swab Instrumen Negative
5.	Kejadian tidak terpasangnya label LED pada instrumen	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan petugas unit terkait penulisan serah terima alat pada buku sertir cssd baik bersih dan kotor	97,47%	92,44%	97,96%										100%	95,95%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
8.	Kepatuhan unit dalam melakukan proses pengiriman dan pengambilan alat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan CSSD (kecuali cito)	96,23%	91,56%	96,43%										100%	94,74%	PDSA
9.	Kejadian tercampurnya benda tajam dengan instrumen kotor	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

26. CLEANING SERVICE

Tabel 3.50 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CS pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan Penggunaan APD	93,06%	84,52%	91,40%										100%	89,66%	PDSA
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	80%	86,90%	92,47%										≥85%	86,45%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kepatuhan clening service dalam	100%	100%	99,47%										100%	99,82%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	membersihkan ruangan pasien setiap 2x dalam sehari untuk pasien non infeksius															
2.	Respon time petugas kebersihan ≤ 15 menit	100%	99,89%	99,79%										100%	99,89%	PDSA
3.	Ketepatan waktu jadwal pengambilan sampah medis dan non medis ≤ 3/4 Tempat sampah	100%	97,28%	98,40%										100%	98,56%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas dalam membersihkan area umum 3x dalam sehari	100%	99,89%	100%										100%	99,96%	Dipertahankan

27. KEAMANAN

Tabel 3.51 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keamanan pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kejadian kehilangan barang milik pasien, penggungjung dan karyawan	2 Kejadian	3 kejadian	2 kejadian										0 kejadian	3 kejadian	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
2.	Kepatuhan petugas keamanan melaksanakan pengawasan keliling RS 2x dalam setiap shift	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan jam berkunjung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
4.	Kejadian kekerasan staf, pasien, & pengunjung di Rumah sakit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian merokok di Area Rumah Sakit	615 kejadian	547 kejadian	615 kejadian										0 kejadian	593 kejadian	PDSA
6.	Kepatuhan penggunaan id card pengunjung di area rumah sakit	87,85%	86,07%	87,85%										100%	87,25%	PDSA
7.	Kepatuhan penggunaan id card staff di area rumah sakit	84,73%	84,88%	84,73%										100%	84,78%	PDSA

28. GUDANG UMUM

Tabel 3.52 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gudang Umum pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan unit dalam pengambilan barang	93,13%	90,91%	87,50%										100%	90,51%	PDSA
2.	Selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)	1,52%	2,89%	1,84%										0%	2,08%	PDSA
3.	Kejadian komplain dari user	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

29. PPI

Tabel 3.53 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PPI pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	89,40%	91,13%	91,92%										≥ 85%	90,81%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan APD	96,54%	93,82%	94,94%										100%	95,10%	PDSA
Indikator Mutu Komite PPI																
1.	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	100%	100%	100%										100 %	100%	Dipertahankan
2.	Kegiatan pencatatan	80%	83,21%	89,03%										75 %	84,08%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)															
3.	Angka infeksi daerah operasi	0,27%	0,28%	0,29%										≤ 1,5%	0,28%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan Penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi)	96,88%	93,07%	100%										100%	96,65%	PDSA
5.	Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam	0 kejadian	2 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
6.	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap	97,02%	95%	96,13%										100%	96,05%	PDSA
7.	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)	99,82%	93,28%	97,51%										100%	96,87%	PDSA
8.	Kepatuhan waktu	95,14%	99,08%	98,98%										100%	97,73%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	pelaporan dari IPCLN ke IPCN															
9.	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 & DUH tubuh	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
10.	Kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok terkait PPI	52,63%	52,63%	44,74%										100%	50%	PDSA

30. PKRS

Tabel 3.54 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PKRS pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Angka pelaksanaan survei kepatuhan PPA dalam memberikan edukasi Kelompok	64,06%	64,06%	46,43%										100%	58,18%	PDSA
2.	Angka pelaksanaan survei kepatuhan PPA dalam pengisian form	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	edukasi kolaborasi															
3.	Angka pelaksanaan survei ketepatan pengisian form edukasi terintegrasi oleh PPA	100%	100%	97,96%										100%	99,32%	PDSA
4.	Kepatuhan staff dalam menggunakan media edukasi melalui elektronik (barcode leaflet)	64,06%	64,06%	53,13%										100%	60,41%	PDSA
5.	Kepatuhan Komunikasi efektif terkait SBAR-TBAK (Konsul DPJP, HO, rujuk internal, rujuk eksternal, konsultasi antar spesialis, pelaporan nilai kritis lab)	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
6.	Kepatuhan pembinaan komunitas berbasis RSPH (prognas dan geriatri)	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

31. ASURANSI CENTER

Tabel 3.55 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Asuransi Center pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Waktu Pengajuan Klaim	Tanggal 5	Tanggal 5	Tanggal 5										Tanggal 5	Tanggal 5	Dipertahankan
2.	% Klaim Pending RJTL	0,04%	0,03%	0,02%										<0,1% dari total klaim	0,03%	Dipertahankan
3.	% Klaim Pending RITL	6,97%	7,60%	7,57%										<1% dari total klaim	7,38%	PDSA
4.	% Klaim Tidak Layak	0,06%	1,06%	0,78%										0% dari total klaim	0,63%	PDSA
5.	Nilai Pengembalian Audit Klaim RJTL	1.141.761.700	22.246.500	0										< Rp 1.000.000	388.002.733	PDSA
6.	Nilai Pengembalian Audit Klaim RITL	4.163.300	5.349.400	4.661.900										< Rp 5.000.000	4.724.866	Dipertahankan
7.	Nilai Selisih Negatif Klaim RJTL	Rp56.592.940	27.812.396	27.812.396										< Rp 50.000.000	37.405.910	Dipertahankan
8.	Nilai Selisih Negatif Klaim RITL	Rp691.112.400	- 424.814.880	- 424.814.880										< Rp 100.000.000	-52.839.120	PDSA

32. HUMAS & MARKETING

Tabel 3.56 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Humas & Marketing pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepuasan Pasien MCU	26,47%	100%	100%										≥ 76,61%	75,49%	Dipertahankan
2.	Ketidakpatuhan perbaruan dokumen kerjasama dengan instansi eksternal	24,59%	24,59%	21,68%										0%	23,62%	PDSA
3.	Kenaikan jumlah Kerjasama dengan pihak eksternal	0%	0%	0%										10% / tahun	0%	Tahunan

33. CSO

Tabel 3.57 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSO pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Resptime CSO <30 mnt (WA)	9,93%	11,59%	10,89%										100%	10,80%	PDSA

34. MOD-MPP-PIPP

Tabel 3.58 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit MOD-MPP pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepuasan Pasien	91,80%	88,10%	89,27%										≥ 76,61%	89,72%	Dipertahankan
2	Respon time penanganan	100%	96,15%	94,74%										100%	96,96%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	complain <5 menit															
Indikator Mutu MOD-MPP-PIPP																
3	Angka kelengkapan Form A & Form B pada pasien sesuai kriteria MPP	86,79%	50,33%	40,38%										100%	59,16%	PDSA
4	Angka kelengkapan form Discharge planning	86,79%	50,33%	40,38%										100%	59,16%	PDSA

35. TB di IRJA

Tabel 3.59 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TB pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Angka kepatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	Belum diisi	Belum diisi	Belum diisi										100%		PDSA
2	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien TB	Belum diisi	Belum diisi	Belum diisi										≥ 90%		PDSA

36. TIM HIV

Tabel 3.60 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TIM HIV pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien HIV	Belum diisi	Belum diisi	Belum diisi										≥ 90%		PDSA

37. KB

Tabel 3.61 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit KB pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan pengisian kartu K4 KB	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2.	Angka terlaksannya program KB pasca persalinan & pasca keguguran	26,89%	23,01%	21,01%										50%	23,63%	PDSA
3.	Semua ibu melahirkan dan curretage mendapatkan KIE KB	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
4.	Angka pelaksanaan pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan	100%	100%	100%										30%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	peserta program KB															

38. STUNTING

Tabel 3.62 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Stunting pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	0%	0%	0%										0%	0%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan petugas melakukan KIE kelompok pada ibu balita1x dalam sebulan	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan Pembinaan jejaring pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting tiap 3 bulan sekali	-	-	-										100%		Triwulanan PDSA
4.	Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan	-	-	-										100%		

39. IT - SIM RS

Tabel 3.63 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit IT – SIM RS pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan sebulan 1 kali	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap penanganan internet dan billing error < 10 mnt	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
3.	Waktu tanggap untuk penanganan computer < 10 menit	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaan computer dan perlengkapannya 1 bulan sekali	100%	100%	100%										100%	100%	Dipertahankan

40. HEMODIALISA

Tabel 3.64 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Hemodialisa pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	98,10%	100%										100%	99,36%	PDSA
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	94,83%	100%	97,37%										≥ 85 %	97,40%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
3.	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	99,05%	100%										100%	99,68%	Dipertahankan
4.	Kepuasan Pasien	100%												≥ 76,61 %		Dipertahankan
5.	Kepatuhan Penggunaan APD	100%	100%	98,46%										100%	99,48%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1.	Kejadian Tidak Adanya Label High Alert pada Obat	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kejadian Ketidaktepatan Pemasangan Akses Vaskuler	2 kejadian	2 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	2 kejadian	Dipertahankan
2.	Kejadian Hipotensi Intra Dialisis	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
3.	Kepatuhan Teknik Steril Perawat HD dalam Pengendalian Infeksi Nosokomial	100%	100%	100%										≥80%	100%	Dipertahankan
4.	Ketepatan Jadwal Hemodialisa	98,36%	93,88%	99,15%										≥95%	97,13%	Dipertahankan
5.	Kejadian Clotting Durante HD	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian										0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
6.	Waktu Pelayanan perawat dari pasien datang sampai proses HD berjalan < 15 menit	95,52%	100%	100%										≥80%	98,50%	Dipertahankan